МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени И.С. ТУРГЕНЕВА»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа
направленность (профиль): Организация социальной работы с разными группами населения и в различных сферах жизнедеятельности

Студента Аллабергенова Атаджана шифр 245625

Отделение заочного и очно-заочного образования
Кафедра политологии, социологии и социальной работы

Тема выпускной квалификационной работы

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ И ДЕТЬМИ, ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Студент _____ Аллабергенов А.

Научный
руководитель _____ к.пед.н., доцент Тюрикова Г.Н.

Зав. кафедрой _____ д.полит.н., профессор Старостенко К.В.

Орёл 2026

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени И.С. ТУРГЕНЕВА»

Институт заочного и очно-заочного образования. Кафедра теории и истории социальной педагогики и социальной работы. Направление подготовки 39.04.02 Социальная работа. Направленность (профиль): Организация социальной работы с разными группами населения и в различных сферах жизнедеятельности.

УТВЕРЖДАЮ:
Зав. кафедрой
Г.Н. Тюрикова
_____
«25» февраля 2026 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы

Студента: Аллабергенова Атаджана шифр 245625

1. Тема ВКР: Деятельность специалиста по социальной работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, утверждена приказом по университету «Об утверждении тем выпускных квалификационных работ» № 8-37 от 25.02.2026.

2. Срок сдачи студентом законченной работы «29» октября 2026 г.

3. Исходные данные к работе: учебная литература, периодические издания, интернет-ресурсы, отчётная документация организации (с базы практики).

4. Содержание ВКР (перечень подлежащих разработке вопросов): изучить теоретические основы деятельности специалиста по социальной работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;

охарактеризовать профессиональный портрет и функции специалиста по социальной работе; определить особенности организации деятельности специалиста по работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; проанализировать современное состояние жизнеустройства детей-сирот в области; определить опыт организации деятельности службы по устройству детей в семью; рассмотреть перспективы функционирования служб по жизнеустройству детей-сирот в области.

5. Перечень графического материала: 5 рисунков.

Дата выдачи задания «25» февраля 2026 года.

Научный руководитель ВКР _____ Тюрикова Г.Н.

Задание принял к исполнению _____ Аллабергенов А.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Выбор темы, закрепление руководителя — 25 февраля 2026 г.

Утверждение плана исследования — 27 февраля 2026 г.

Обзор литературы, представление первой главы — 18 мая 2026 г.

Представление второй главы — 20 сентября 2026 г.

Предоставление окончательного варианта работы — 29 октября 2026 г.

Научный руководитель ВКР _____ Тюрикова Г.Н.

Задание принял к исполнению _____ Аллабергенов А.

АННОТАЦИЯ

Ключевые слова: специалист по социальной работе, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, семейное устройство, опека, усыновление, приёмная семья, индивидуальный план развития, Орловская область.

Цель выпускной квалификационной работы — проанализировать организацию деятельности специалиста по социальной работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, и предложить практические меры по повышению её эффективности на основе дорожной карты и логики индивидуального плана развития.

Для достижения цели решаются следующие задачи: 1. Раскрыть теоретические и нормативно-правовые основы социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Российской Федерации. 2. Охарактеризовать профессиональный портрет и функции специалиста по социальной работе с данной категорией детей. 3. Проанализировать жизнеустройство детей-сирот в Орловской области и опыт служб семейного устройства. 4. Разработать дорожную карту и подходы к индивидуальному плану развития с приоритетом семейного устройства и учётом профессиональных барьеров.

Объект исследования — система социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Предмет исследования — содержание, формы и методы деятельности специалиста по социальной работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.

В работе рассматривается роль специалиста в условиях деинституционализации и приоритета семейных форм устройства, выявляются типичные трудности практики — формализм индивидуальных планов, фрагментарность межведомственного взаимодействия, риск профессионального выгорания — и намечаются пути совершенствования сопровождения на материале Орловской области.

В первой главе изучаются теоретические основы деятельности специалиста, правовой контур защиты детства и профессиональный портрет специалиста по социальной работе.

Во второй главе анализируется практика жизнеустройства в Орловской области, опыт служб семейного устройства и разрабатываются дорожная карта и логика индивидуального плана развития ребёнка.

Методы исследования: анализ нормативных и литературных источников, изучение отчётных и статистических данных, качественный и количественный анализ, обобщение, графическое представление результатов.

Основные результаты направлены на совершенствование повседневной работы специалиста: от диагностики и планирования до устойчивого семейного устройства и постинтернатной поддержки.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 8
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ И ДЕТЬМИ, ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ... 11
1.1 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, как объект социальной работы ... 11
1.2 Профессиональный портрет и функции специалиста по социальной работе 33
Выводы по главе 1 52
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА И РАЗРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ ... 54
2.1 Современное состояние системы жизнеустройства детей-сирот в регионе и опыт организации деятельности службы по устройству детей в семью ... 54
2.2 Разработка дорожной карты и индивидуального плана развития детей-сирот 60
Выводы по главе 2 75
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 79
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 83

ВВЕДЕНИЕ

Защита прав ребёнка в современной России — рабочий приоритет социальной политики и практики. Конвенция о правах ребёнка прямо требует: «наилучшие интересы ребёнка являются первоочередным соображением»[2]. Семейный кодекс закрепляет ту же ось: «каждый ребёнок имеет право жить и воспитываться в семье»[5]. Конституция поддерживает линию нормой: «материнство и детство, семья находятся под защитой государства»[4]. Курс на деинституционализацию здесь нельзя свести к лозунгу: речь о том, чтобы увести ребёнка от длительного институционального пребывания к кровной или замещающей семье. Е. И. Холостова формулирует приоритет ясно: «приоритетом социальной политики выступает сохранение ребёнка в кровной семье и, при невозможности этого, устройство в замещающую семью»[59]. Она же уточняет условие результата: «социальная работа с детьми-сиротами эффективна лишь при согласованности органов опеки, учреждений и служб сопровождения»[59].

Категория детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, остаётся сложным объектом сопровождения. В литературе сиротство определяют как «социальное явление, обусловленное наличием в обществе детей, родители которых умерли, а также детей, оставшихся без попечения родителей вследствие лишения родительских прав, признания родителей недееспособными, безвестно отсутствующими и в иных случаях, установленных законом»[45]. Доминирует социальное сиротство, поэтому специалисту приходится работать с последствиями неблагополучия и депривации. Ф. А. Мустаева отмечает: «социальная дезадаптация детей и подростков тесно связана с неблагополучием семейной среды и недостатком положительного общения со взрослыми»[47]. И. В. Дубровина подчёркивает: «особенности психического развития детей вне семьи требуют специального психолого-педагогического сопровождения»[36]. В. С. Мухина показывает глубину институционального влияния: «воспитанники домов ребёнка

аутичны, у них слабо выражена потребность к общению, наблюдается общая задержка развития»[62]. М. К. Бардышевская добавляет: «нарушения привязанности у детей, воспитывающихся вне семьи, проявляются в сочетании потребности в близости с неумением её реализовать конструктивно»[63]. Отсюда смена оптики: от обеспечения базовых условий — к комплексному сопровождению и ведению случая.

Нормативная рамка задаёт специалисту конкретный алгоритм. Федеральный закон № 159-ФЗ говорит о «дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»[10], включая право «на обеспечение жилыми помещениями»[10]. Закон об опеке и попечительстве ориентирует на то, что «опека и попечительство устанавливаются для защиты прав и интересов»[11]. Закон о профилактике безнадзорности требует «индивидуальной профилактической работы»[9]. Методические рекомендации Минпросвещения России (письмо от 31.01.2025 № АБ-318/07) усиливают роль индивидуального плана развития и жизнеустройства как рабочего инструмента. М. О. Егорова точно ловит смысл ранней помощи: «профилактика сиротства становится актуальной задачей социальных служб именно тогда, когда помощь семье оказывается до лишения родительских прав»[38].

Степень изученности темы высока у Е. И. Холостовой, Л. С. Алексеевой, А. М. Панова, И. В. Дубровиной, М. К. Бардышевской, В. С. Мухиной, Т. Я. Сафоновой и Н. Ф. Плясовой. Операциональная сторона — ведение случая, индивидуальный план, межведомственная связка, профилактика профессионального выгорания — нуждается в прикладном осмыслении. П. Я. Циткилов фиксирует: «технология социальной работы требует… устойчивых навыков межведомственной координации»[56]. Н. П. Иванова и И. А. Бобылева добавляют: «адаптация ребёнка в замещающей семье начинается ещё до передачи — с диагностики ресурсов ребёнка и подготовки взрослых»[39]. В. Н. Ослон предупреждает: «замещающая семья нуждается в сопровождении на всём протяжении адаптации»[71]. И. А.

Бобылева уточняет: «переподготовка действующих опекунов — это не формальность, а способ снизить вторичное сиротство»[72]. Для Орловской области тема практична: службы семейного устройства работают, но остаются зоны напряжения — качество планов, вторичные отказы, жилищный контур, кадровые барьеры.

Объект исследования — система социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Предмет исследования — содержание, формы и методы деятельности специалиста по социальной работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.

Цель работы — проанализировать организацию деятельности специалиста по социальной работе с данной категорией детей и разработать рекомендации по повышению её эффективности через ведение случая, индивидуальный план развития и межведомственное сопровождение.

Задачи исследования: 1. Изучить теоретические подходы и нормативно-правовую базу социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 2. Раскрыть профессиональный портрет и функции специалиста по социальной работе с данной категорией детей. 3. Проанализировать жизнеустройство детей-сирот в Орловской области и опыт служб семейного устройства. 4. Выявить профессиональные барьеры, включая формализм планирования, фрагментарность взаимодействия служб и риск профессионального выгорания. 5. Разработать дорожную карту и подходы к индивидуальному плану развития с приоритетом семейного устройства.

Методы исследования: анализ научной и нормативной литературы, изучение отчётных и статистических данных, качественный и количественный анализ, обобщение, графическое представление результатов.

Практическая значимость: рекомендации применимы в учреждениях Орловской области при корректировке сопровождения, шаблонов индивидуального плана и мер профилактики профессионального выгорания.

Как подчёркивает профессиональная периодика, «эффективность сопровождения измеряется не числом мероприятий, а устойчивостью семейного устройства и качеством жизни ребёнка»[86].

Структура работы: введение, две главы, заключение и список источников. Первая глава — теоретические основы и профессиональный портрет; вторая — практика Орловской области, дорожная карта и индивидуальный план развития.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ И ДЕТЬМИ, ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

1.1 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, как объект социальной работы

Сиротство как социальное явление существует столько же, сколько существует человеческое общество, и является неотъемлемым элементом цивилизации. Во все времена войны, эпидемии, стихийные бедствия и иные причины приводили к гибели родителей, вследствие чего дети становились сиротами. В научной литературе сиротство определяют как «социальное явление, обусловленное наличием в обществе детей, родители которых умерли, а также детей, оставшихся без попечения родителей вследствие лишения родительских прав, признания родителей недееспособными, безвестно отсутствующими и в иных случаях, установленных законом»[45]. К этой же группе относят несовершеннолетних, чьи родители формально не лишены прав, но фактически не осуществляют заботу о детях. Как подчёркивает Е. И. Холостова, «сиротство отражает состояние общества и качество семейной политики, а работа с детьми данной категории составляет одно из центральных направлений социальной работы»[59]. Для специалиста по социальной работе важно различать правовые категории и социально-психологическое содержание ситуации ребёнка: формальный статус

определяет набор гарантий, а реальный опыт утраты семьи — содержание помощи.

В российском праве закон не проводит принципиального различия между детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, с точки зрения общих принципов и мер государственной поддержки. В Семейном кодексе Российской Федерации понятие «дети-сироты» отсутствует: такие дети также рассматриваются как оставшиеся без попечения родителей[21]. Вместе с тем Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ о «дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»[10] закрепляет развёрнутые определения категорий, имеющих значение для практики социальной работы.

Дети-сироты — это «лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель»[3]. Данный вид утраты семейной заботы принято называть биологическим (кровным) сиротством; на его долю приходится около 10–12 % от общего числа детей рассматриваемой категории[2]. Дети, оставшиеся без попечения родителей, — более широкая категория: «лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением их родительских прав, ограничением в родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением умершими, отбыванием наказания в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей, уклонением от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из образовательных, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, а также в иных случаях признания детей оставшимися без попечения родителей в установленном законом порядке»[3]. Именно эта группа формирует феномен социального сиротства, которое сегодня является доминирующей проблемой в данной сфере[1][2].

Отдельно выделяются лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — «лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а также которые остались без попечения единственного или обоих родителей и имеют в соответствии с настоящим Федеральным законом право на дополнительные гарантии по социальной поддержке»[3]. Закон также определяет организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, как «образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, в которые помещаются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей»[3]. Опека и попечительство закрепляются как «форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также для защиты их прав и интересов»[3]; опека устанавливается над детьми, не достигшими 14 лет, попечительство — над детьми от 14 до 18 лет. Приёмная семья определяется как «форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на основании договора о передаче ребёнка на воспитание в семью между органами опеки и попечительства и приёмными родителями»[3]. Полное государственное обеспечение включает «предоставление за время пребывания в организации или в семье опекуна, попечителя, приёмных родителей бесплатного питания, комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, проживания без взимания платы, а также бесплатное оказание медицинской помощи»[3].

Наиболее острым явлением последних десятилетий стало значительное увеличение масштабов социального сиротства и появление его новых характеристик. Обнаруживается так называемое скрытое социальное сиротство, связанное с ухудшением условий жизни семьи, падением её нравственных устоев и изменением отношения к детям вплоть до их полного вытеснения из семей. В результате растёт безнадзорность и беспризорность значительного числа детей и подростков. Социальное сиротство понимается как «явление устранения или неучастия большого круга лиц в выполнении

ими родительских обязанностей (искажение родительского поведения)»[48]. В обязанности родителей входит воспитывать детей, готовить их к общественно полезному труду, содержать несовершеннолетних, защищать их права и интересы во всех учреждениях. Л. Я. Олиференко отмечает, что «социальное сиротство выступает следствием кризиса семьи и требует от специалистов социальной работы сочетания мер защиты ребёнка с поддержкой кровной семьи, когда это возможно и безопасно»[48].

В силу несовершенства системы учёта и высокой динамики роста численности детей, утративших попечение родителей, точное количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в нашей стране определить сложно. По ряду оценок, оно составляет от 500 до 700 тысяч человек. Нестабильность социально-экономической и политической ситуации значительно обостряет проблему. «Кризис семьи, нарушение её структуры и функций, падение жизненного уровня, обесценивание морально-нравственных идеалов, изменение ориентиров ведут к значительному росту социальной дезадаптации детей, которая прежде всего проявляется в утрате социальных связей с семьёй»[47]. Это ведёт к обострению проблем социального сиротства, росту числа несовершеннолетних бродяг и подростков группы риска. Ф. А. Мустаева подчёркивает: «социальная дезадаптация детей и подростков тесно связана с неблагополучием семейной среды и недостатком положительного общения со взрослыми»[47]. П. Я. Циткилов отмечает: «социальное сиротство в современной России носит преимущественно социальный, а не биологический характер, что требует переноса акцента на работу с кровной семьёй»[56]. Н. Ф. Плясова пишет: «учёт детей, оставшихся без попечения родителей, осложняется скрытыми формами семейного неблагополучия и безнадзорности»[65].

Появление детских учреждений (институтов) вызвало неоднозначное отношение и стремление разобраться в том, как они влияют на психическое развитие детей, а также породило проблему институционализации — вопрос об особенностях формирования личности и поведения ребёнка, посещающего

общественные детские учреждения. Долгое время широко бытовало убеждение, что развитие детей в таких учреждениях сильно отстаёт; многие учёные подчёркивали губительное и необратимое негативное действие институтов на психику детей. «Ко всему психическому развитию дети, воспитывающиеся без попечения родителей, отличаются от ровесников, растущих в семье. Темп развития первых замедлен. Их развитие и здоровье имеют ряд качественных негативных особенностей, которые отличаются на всех ступенях детства — от младенчества до подросткового возраста и дальше»[58]. Особенности по-разному и в неодинаковой степени обнаруживают себя на каждом возрастном этапе, но все они чреваты серьёзными последствиями для формирования личности. Л. М. Шипицына пишет: «длительное пребывание ребёнка в условиях интернатного учреждения формирует специфический тип личности с нарушенной эмоциональной сферой и ограниченным репертуаром социальных ролей»[58]. В русле культурно-исторической теории Л. С. Выготского развитие ребёнка понимается как процесс, опосредованный общением со взрослым: «высшие психические функции возникают первоначально как формы коллективного поведения ребёнка, как формы сотрудничества с другими людьми»[32]. При дефиците содержательного сотрудничества со взрослым в учреждении интернатного типа страдает именно это звено развития. А. Е. Личко указывал, что «подростковый возраст особенно уязвим к условиям воспитания: при неблагоприятной среде усиливаются акцентуации характера и риск отклоняющегося поведения»[42]. Для воспитанников интернатных учреждений это означает дополнительную нагрузку на и без того ослабленные механизмы саморегуляции.

Исследования показывают, что лишение детей материнской заботы с последующей психической депривацией в сиротских учреждениях катастрофически сказывается на их социальном, психическом и физическом здоровье. «Большинству брошенных детей не хватает личного внимания и эмоционального стимулирования, необходимого для развития»[69].

Наблюдая у таких детей тяжёлые повреждения личности, самосознания и интеллектуального развития, учёные высказывали предположение о том, что эмоциональная депривация делает особенно актуальным сам момент отторжения. Этот травмирующий комплекс сохраняется у ребёнка на всю жизнь. «Дети, изолированные с рождения до шести месяцев, навсегда остаются менее разговорчивы, чем их сверстники из семей. Изоляция ребёнка от матери от одного до трёх лет обычно приводит к тяжёлым последствиям для интеллекта и личностных функций, которые не поддаются исправлению»[70]. Разлука с матерью, начиная со второго года жизни, также ведёт к устойчивым последствиям, хотя интеллектуальное развитие может нормализоваться. Й. Лангмейер и З. Матейчек связывают эти эффекты с психической депривацией как «состоянием, возникающим вследствие таких жизненных ситуаций, где субъекту не предоставляется возможности для удовлетворения некоторых основных психических потребностей в достаточной мере и в течение достаточно длительного времени»[69][70].

Сиротство — это социальная проблема, решить её раз и навсегда невозможно. Поэтому социальная политика государства должна осуществляться в двух направлениях: профилактика социального сиротства (эффективная семейная политика, оказание помощи одиноким матерям, половое просвещение и т. д.) и развитие системы социальной защиты и воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Е. И. Холостова формулирует это следующим образом: «государственная политика в отношении детей-сирот должна сочетать предупреждение социального сиротства с созданием условий для полноценного устройства и воспитания ребёнка, утратившего семейную заботу»[59]. М. Н. Гуслова пишет: «профилактика социального сиротства предполагает раннее выявление семейного неблагополучия и оказание комплексной помощи семье до момента изъятия ребёнка»[77]. Л. Е. Никитина отмечает: «социальная работа с семьёй группы риска направлена на сохранение ребёнка в кровной семье при условии обеспечения его безопасности и прав»[78]. И. Ф. Дементьева

подчёркивает: «рост социального сиротства связан с изменением ценностных установок родителей и ослаблением воспитательной функции семьи»[80]. При безответственном поведении родителей дети без должного присмотра попадают в группу риска: дефицит общения со взрослыми нередко компенсируется уличными связями, что ухудшает здоровье, развитие и социализацию.

Изучая факторы, определившие в сознании детей установку на бродячий образ жизни, прежде всего выделяют тяжёлое материальное положение семей, в которых родители не способны осуществлять нормальный воспитательный процесс. Материальный фактор напрямую влияет на общий моральный климат в семье и поведение старших членов семьи. Конфликты с родителями, пьянство, ссоры и наркомания последних, жестокое обращение с детьми — вторая основная детерминанта. Если она сопровождается неудачами в школе, создаётся комплекс причин, который предопределяет решение ребёнка бежать из дома. Т. Я. Сафонова отмечает: «жестокое обращение и безнадзорность в семье выступают ведущими факторами риска, толкающими ребёнка к уходу из дома и попаданию в социально опасное положение»[64]. Беспризорный — несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении: «лицо в возрасте до 18 лет, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья, либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные действия»[6].

Значение семьи определяется теми условиями, которые в ней создаются для развития ребёнка, для усвоения им общечеловеческого опыта. С самого раннего возраста ребёнок учится у взрослых. Учится не только ходить, говорить, правильно пользоваться предметами, играть, получать знания, трудиться, но и чувствовать, думать, переживать, относиться к другим людям и к себе самому. «Особенность семейного воспитания состоит в его эмоциональном характере, основанном на любви, доверии, взаимной

заинтересованности. Семья — первая школа общения, где дети с ранних лет усваивают целостную систему нравственных ценностей и идеалов, культурные традиции данного общества и специфической социальной среды»[44]. Л. В. Мардахаев подчёркивает: «вне семьи эмоциональная насыщенность общения и устойчивость привязанностей воспроизводятся лишь частично, что определяет своеобразие социализации воспитанников интернатных учреждений»[44].

Недостаточное интеллектуальное развитие ребёнка может выражаться в ослаблении познавательных процессов, неустойчивости внимания, слабой памяти и снижении абстрактно-логического мышления. Как показывают исследования, «основными причинами снижения интеллектуального развития воспитанников общеобразовательных интернатных учреждений являются средовые влияния, педагогическая запущенность, а не врождённо-наследственные факторы»[36]; без своевременной помощи это ведёт к отставанию в учёбе и затрудняет взаимодействие ребёнка с окружающими.

Психологические исследования уровня и особенностей интеллектуального развития воспитанников свидетельствуют, что уровень развития внимания и памяти воспитанников не имеет существенных отклонений от среднестатистической нормы. Однако исследования выявляют «слабо сформированную картину мира, повышенную ситуативность, которая в познавательной сфере проявляется в неспособности решения задач, требующих внутренних операций, без опоры на практические действия, снижение развития абстрактно-логического мышления, особенно у детей среднего школьного возраста. Наиболее выражено снижение вербально-логического мышления»[36]. Большую трудность для дошкольников и младших школьников представляет внеситуативно-личностная беседа. Как правило, вопросы «кто вам больше нравится?», «что вы любите?», «какое у вас настроение?» вызывают смущение детей, и они ничего не могут на них ответить. И. В. Дубровина указывает: «основными причинами снижения интеллектуального развития воспитанников общеобразовательных

интернатных учреждений являются средовые влияния, педагогическая запущенность, а не врождённо-наследственные факторы, анатомо-физиологические нарушения работы центральной нервной системы»[36]. Одной из причин является отсутствие качественного, содержательного общения со взрослыми, которое было бы адекватно для детей, воспитывающихся в детском доме.

Наибольшие трудности и отклонения от нормального становления личности воспитанников детских домов отмечаются всеми исследователями в эмоционально-волевой сфере: «в нарушении социального взаимодействия, неуверенности в себе, снижении самоорганизованности, целеустремлённости, недостаточном развитии самостоятельности („силы личности“), неадекватной самооценке, неуверенности в себе, неспособности выстроить нормальные взаимоотношения с окружающими, вплоть до полного отсутствия тенденции к сотрудничеству»[58]. Нарушения проявляются в тревожности, эмоциональной напряжённости, агрессивности или холодности, трудностях контакта и снижении готовности преодолевать препятствия.

«Неполнота эмоциональной жизни в сиротских учреждениях вызывает у ребёнка в старшем возрасте различные психические расстройства и нарушения социальной адаптации: у одних это тенденция к понижению активности, ведущая к апатии и большему интересу к вещам, чем к людям; у других — гиперактивность с уходом в асоциальную и криминальную деятельность; у многих наблюдается тенденция вести себя вызывающе в обществе, пытаясь привлечь к себе внимание при неумении создавать прочные эмоциональные привязанности»[63]. Подобные нарушения объясняются всем предыдущим развитием детей, а также условиями пребывания воспитанников в учреждениях закрытого типа. М. К. Бардышевская отмечает: «нарушения привязанности у детей, воспитывающихся вне семьи, проявляются в сочетании потребности в близости с неумением её реализовать конструктивно»[63].

Значительная часть детей поступает в детские дома из домов ребёнка, где они воспитывались до трёх, иногда до четырёх лет. Учреждения, где воспитываются дети раннего возраста, как известно, несут в своей системе условия для развития госпитализма. Результаты исследований, проведённых академиком В. С. Мухиной, свидетельствуют: «воспитанники домов ребёнка аутичны, у них слабо выражена потребность к общению, наблюдается общая задержка развития. Эти дети часто отстают в речевом развитии, не умеют играть, не умеют общаться. В свои первые годы жизни они отличаются несвойственной детству пассивностью»[62]. Лишённый материнской заботы и полноценного общения со взрослыми, ребёнок уже в младенчестве утрачивает потенциал активного развития и становится пассивным; в закрытом учреждении часто закрепляются стереотипные «тупиковые» движения и общая заторможенность поведения.

«Ребёнок, растущий в условиях учреждений интернатного типа, как правило, не осваивает навыки продуктивного общения. Его контакты поверхностны, нервозны и поспешны: он одновременно домогается внимания и отторгает его, переходя на агрессию или пассивное отчуждение. Нуждаясь в любви и внимании, он не умеет вести себя таким образом, чтобы с ним общались в соответствии с этой потребностью»[62]. У воспитанников ярко проявляется эмоциональный голод: они легко вступают в контакт с любым взрослым, но предпочитают физический контакт содержательной совместной деятельности; деловые контакты возникают поздно, а равноправное участие в игре даётся с трудом. «Активность в сотрудничестве, стремление и способность что-либо делать вместе со взрослым у детей не возникает. Попытка взрослого аргументировать привлекательность совместной игры, деятельности может вызвать внезапное отчуждение, демонстрацию показного безразличия, представляющего вариант защитного поведения»[66].

Эмоции являются важнейшим компонентом в целостной картине поведения ребёнка дошкольного и младшего школьного возраста, его

деятельности, отношения к миру, окружающим людям и самому себе. Специфические условия жизни в учреждении интернатного типа, эмоциональная депривация нарушают психическое развитие ребёнка, искажают его эмоциональную сферу. В характеристике эмоционального портрета воспитанника детского дома перечисляют: «пониженный фон настроения; бедную гамму эмоций, однообразие эмоционально-экспрессивных средств общения; склонность к быстрой смене настроения; однообразность и стереотипность эмоциональных проявлений; эмоциональную поверхностность; неадекватные формы эмоционального реагирования на одобрение и замечание; повышенную склонность к страхам, тревожности и беспокойству; основную направленность положительных эмоций на получение всё новых и новых удовольствий; непонимание эмоционального состояния другого человека; чрезмерную импульсивность, аффективную взрывчатость»[58]. У дошкольников возбудимость нередко сочетается с истощаемостью и раздражительностью; причины отклонений включают не только депривацию, но и наследственные и врождённые факторы.

В целом потребность в общении со сверстниками у воспитанников выражена слабее: контакты бедны по содержанию, в игре дети часто играют порознь или без подлинного ролевого взаимодействия, а конфликты протекают резко. «Ситуативность в поведении, неспособность к конструктивному решению проблем, организации своей деятельности, самостоятельному соблюдению правил игры обусловлена тем, что уже общение детей со взрослыми в детском доме не предоставляет ребёнку самостоятельности, а, наоборот, резко ограничивает её твёрдым режимом дня, постоянными указаниями взрослого, контролем со стороны взрослого, формируя тем самым привычку к „пошаговому“ выполнению чужих указаний»[67].

Академик В. С. Мухина обращает внимание на серьёзные нарушения в формировании структуры самосознания детей-сирот. Исходная позиция

исследователя состоит в том, что «самосознание человека развивается внутри следующей исторически сложившейся, социально обусловленной структуры: имя собственное плюс личное местоимение; притязание на признание; половая идентификация; психологическое время личности: самобытие в прошлом, настоящем, будущем; социальное пространство: долг и права»[62]. В детских домах к детям нередко обращаются по фамилии, имя часто сочетается с фамилией. Часто имя используется для приказа и почти никогда для проявления любви. В результате у ребёнка формируется отрицательное отношение к своему имени. Притязания ребёнка чаще реализуются в собственной среде через физическую силу, через адекватную для воспитанников агрессию, а порой — через асоциальные формы поведения. «Невозможность реализации потребности в признании приводит к аффективным срывам, к ощущениям гнетущего напряжения, тревожности, отчаяния, гнева, к сужению диапазона сопереживания»[62].

Исследователь обращает внимание ещё на одну важную проблему — феномен «мы» в условиях детского дома. «В условиях жизни без родительского попечительства у детей стихийно складывается детдомовское (интернатское) „мы“. Это совершенно особое психологическое образование. Дети без родителей делят мир на „своих“ и „чужих“, на „мы“ и „они“. От „чужих“ они все вместе готовы извлекать свои выгоды. У них своя особая нормативность по отношению ко всем „чужим“ и своим детдомовцам»[62]. Внутри своей группы дети, живущие в интернате, могут жестоко обращаться со своим сверстником или ребёнком младшего возраста. Эта позиция вызвана многими причинами, но прежде всего нереализованной потребностью в любви и признании, эмоционально нестабильным положением ребёнка, лишённого родительского попечительства. У этих детей масса проблем, которые неведомы ребёнку в нормальной семье. Они психологически отчуждены от людей, и это открывает им «право» к правонарушению. В школе, куда дети из детского дома ходят учиться, одноклассники из семей выступают в их сознании как «они», что развивает сложные конкурентные,

негативные отношения детдомовских и домашних детей. У воспитанников детских домов разрушено ещё одно важное звено самосознания — звено психологического времени личности. «Ребёнок не в состоянии соотнести себя настоящего с собой в прошлом и будущем: индивидуального прошлого они часто не помнят, будущее для них неопределённо»[62].

Нравственное развитие является одной из основных проблем полноценного личностного роста воспитанников. Проблемы нравственного развития начинаются с младшего школьного возраста и проявляются чаще всего в кражах, безответственности, подавлении и оскорблении более слабых, в снижении эмпатии, способности к сочувствию, сопереживанию и, в целом, в недостаточном понимании или непринятии моральных норм, правил и ограничений. Если воспитанники младшего возраста совершают те или иные аморальные поступки чаще всего по недомыслию, импульсивному желанию получить желаемое, слабо понимая чувства и желания окружающих, или из-за импульсивного желания отомстить обидчику, то проблемы нравственного развития воспитанников старшего возраста имеют более серьёзный характер. «Большинство воспитанников-подростков имеют низкую моральную устойчивость, которая выражается в достаточно осознанном терпимом отношении к лицам, совершающим аморальные поступки и деяния, в нечестности, снижении социальной ответственности и отсутствии угрызений совести как внутреннего индикатора отклонения от нравственных норм»[79]. С. А. Беличева подчёркивает: «нравственное развитие воспитанников, хотя и является наиважнейшей составляющей позитивного развития личности, во многом зависит и является следствием нарушений общеинтеллектуального и эмоционально-волевого развития личности»[79].

К одной из наиболее актуальных проблем воспитанников интернатных учреждений исследователи относят и трудности социализации детей-сирот. Под трудностью социализации специалисты понимают комплекс затруднений ребёнка при овладении той или иной социальной ролью.

Родившись, ребёнок сразу попадает в мир социальных отношений — мир отношений между людьми, в которой каждый играет множество ролей: семьянина, друга, соседа, жителя города, деревни и т. д. Осваивая эти роли, человек социализируется, становится личностью. «Отсутствие нормальных для обычного ребёнка контактов (семья, друзья, соседи и т. п.) приводит к тому, что образ роли создаётся на основе противоречивой информации, получаемой ребёнком из различных источников. В связи с этим часто возникает иллюзорный „образ“ социальной роли. Формируется ложное представление о своей социальной роли как сироты. Эта роль реализуется человеком в течение всей его жизни»[57]. В связи с трудностями социализации не решаются и задачи адаптации, автономизации и активизации личности. А. Ш. Шахманова отмечает: «успешная социализация ребёнка-сироты возможна лишь при условии целенаправленного формирования социальных компетенций и устойчивых связей с принимающим взрослым»[57].

Таким образом, результаты психологического обследования свидетельствуют о значительных проблемах развития личности большинства воспитанников детских домов во всех возрастных группах. «Наибольшие трудности и отклонения от нормального становления личности наблюдаются в эмоционально-волевой сфере, нарушении социального взаимодействия, неуверенности в себе, снижении самоорганизованности и целеустремлённости, что приводит к значительному ослаблению „силы личности“»[58]. Негативные тенденции развития личности воспитанников сохраняются во всех возрастных группах и в старшей возрастной группе проявляются, в частности, в снижении профессиональной пригодности ко многим видам профессиональной деятельности, особенно интеллектуального характера и социального взаимодействия. И. А. Бобылева указывает: «подготовка воспитанников к самостоятельной жизни должна начинаться задолго до выпуска и включать освоение бытовых, правовых и коммуникативных навыков»[72].

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, представляют собой одну из наиболее сложных и уязвимых категорий объектов социальной работы. В российской научной и правовой традиции их статус строго регламентирован, а специфика жизненной ситуации требует от специалистов применения комплексных междисциплинарных подходов. П. Д. Павленок пишет: «объект социальной работы — это индивиды, группы, общности, находящиеся в трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в социальной помощи, защите и поддержке»[50]. М. В. Фирсов уточняет: «дети-сироты как объект профессиональной деятельности специалиста по социальной работе требуют сочетания правового, психолого-педагогического и организационного воздействия»[75]. Н. Ф. Басов отмечает: «социальная работа с детьми, оставшимися без попечения родителей, включает диагностику социальной ситуации, защиту прав, организацию устройства и сопровождение ребёнка на всех этапах»[89]. И. Г. Зайнышев подчёркивает: «технология социальной работы с сиротами должна быть ориентирована на восстановление социальных связей и подготовку к самостоятельной жизни»[88]. Е. Р. Ярская-Смирнова указывает: «институциональные формы воспитания нуждаются в критическом анализе с позиций прав ребёнка и качества повседневной заботы»[84].

Специфика данной категории определяется прежде всего дефицитом базового доверия и нарушением привязанности: в депривационных условиях дети испытывают трудности в близких отношениях и склонны к манипулятивному поведению либо к неразборчивой общительности. Социальная работа здесь направлена на формирование безопасной привязанности через наставничество. В. Н. Ослон отмечает: «замещающая семья и наставничество способны компенсировать дефицит привязанности, если сопровождение носит длительный и профессионально организованный характер»[71]. Г. В. Семья подчёркивает: «успешная постинтернатная адаптация зависит от наличия значимого взрослого и поэтапного освоения навыков самостоятельной жизни»[86].

Разрыв с кровной семьёй воспринимается как утрата части идентичности и часто сопровождается тревожностью, низкой самооценкой, агрессией или задержками развития. Специалист координирует работу с психологами для преодоления последствий травмы. Н. К. Малярова пишет: «реабилитация ребёнка, пережившего семейную депривацию, невозможна без учёта травматического опыта и восстановления доверия к взрослому»[43]. Т. И. Шульга указывает: «работа с ребёнком группы риска предполагает диагностику семейной ситуации, защиту прав несовершеннолетнего и восстановление нарушенных социальных связей»[73].

Выходцы из учреждений часто не обладают бытовыми и правовыми навыками: привычка к полному государственному обеспечению порождает иждивенческую позицию и трудности с планированием бюджета и ответственностью[4]. Е. А. Морозова отмечает: «правовой инфантилизм выпускников интернатных учреждений проявляется в незнании собственных прав и обязанностей и в ожидании полного государственного обеспечения»[87].

Как объект социальной работы ребёнок-сирота нуждается в защите сразу нескольких групп прав. Жилищные: право на получение специализированного жилого помещения по достижении 18 лет (формирование списков нуждающихся начинается с 14 лет)[3]. Образовательные: квоты на обучение, полное государственное обеспечение во время учёбы, бесплатный проезд и второе среднее профессиональное образование[3][4]. Медицинские: бесплатная высокотехнологичная помощь, диспансеризация и оздоровление[3]. Трудовые и финансовые: пособие по безработице в повышенном размере в течение первых шести месяцев поиска работы, единовременные выплаты при окончании учебного заведения[3]. Дополнительные гарантии по социальной поддержке определяются законом как «законодательно закреплённые дополнительные меры по социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя»[3]. Полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии при получении профессионального образования включают предоставление обучающимся по очной форме бесплатного питания, комплекта одежды и мягкого инвентаря или возмещение их полной стоимости, предоставление жилого помещения в порядке, предусмотренном законодательством об образовании, а также бесплатное оказание медицинской помощи до завершения обучения[3]. Выпускники организаций для детей-сирот определяются как «лица, которые помещены под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на полное государственное обеспечение и завершили своё пребывание в данной организации»[3]. Именно на этапе выпуска наиболее остро проявляется дефицит социальных компетенций и потребность в сопровождении.

Российская Федерация является участницей ключевых международных договоров, устанавливающих стандарты прав ребёнка: Конвенции ООН о правах ребёнка 1989 года, Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей, Минимальных стандартных правил ООН, касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних[2][8]. Декларация прав ребёнка 1959 года является первым международным документом, в котором родители, добровольные организации, местные власти и национальные правительства призываются к признанию и соблюдению прав детей путём законодательных и других мер. В десяти принципах, изложенных в Декларации, провозглашаются «права детей на имя, гражданство, любовь, понимание, материальное обеспечение, социальную защиту и предоставление возможности получать образование и развиваться физически, умственно, нравственно и духовно в условиях свободы и достоинства»[8]. Особое внимание уделяется защите ребёнка:

«ребёнок должен своевременно получать помощь и быть защищён от всех форм небрежного отношения, жестокости и эксплуатации»[8].

Принятие Конвенции о правах ребёнка стало значительным событием в области защиты прав детей. В Конвенции впервые ребёнок рассматривается не только как объект, требующий специальной защиты, но и как субъект права, которому предоставлен весь спектр прав человека. Конвенция состоит из преамбулы и пятидесяти четырёх статей, детализирующих индивидуальные права каждого человека в возрасте до восемнадцати лет. Конвенция признаёт за каждым ребёнком, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального, этнического и социального происхождения, юридическое право на воспитание, развитие, защиту, активное участие в жизни общества. «Государства-участники признают право каждого ребёнка на уровень жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития»[8]. Конвенция увязывает права ребёнка с обязанностями родителей и предоставляет ребёнку право на участие в решениях, затрагивающих его интересы.

Основные естественные права ребёнка в Конвенции по сути повторяют основные права взрослого, записанные во Всеобщей декларации прав человека. Так, государства-участники уважают права ребёнка на свободу мысли, совести и религии; ребёнок имеет право свободно выражать своё мнение; это право включает свободу искать, получать и передавать информацию и идеи любого рода. «Государства-участники принимают все необходимые законодательные, административные, социальные и просветительные меры с целью защиты ребёнка от всех форм физического или психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного и грубого обращения или эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление»[8]. Признаются право ребёнка на отдых и досуг, право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях; право ребёнка на защиту от экономической эксплуатации и от выполнения

любой работы, которая может представлять опасность для его здоровья или служить препятствием в получении им образования. Согласно Конвенции, образование ребёнка должно быть направлено «на развитие личности, талантов и умственных и физических способностей ребёнка в их самом полном объёме; воспитание уважения к правам человека и основным свободам; воспитание уважения к родителям ребёнка, его культурной самобытности, языку и ценностям; подготовку ребёнка к сознательной жизни в свободном обществе; воспитание уважения к окружающей природе»[8].

Конвенция о правах ребёнка признана документом международного права и впервые создала механизм контроля — Комитет по правам ребёнка, рассматривающий доклады государств. Сама Конвенция не является актом прямого действия и служит основой для национального законодательства. После её ратификации в России были приняты программа «Дети России», Семейный кодекс РФ и ряд федеральных законов о поддержке детских объединений[1][5][21]. Семейный кодекс предусматривает «существенное усиление гарантий прав детей в семейных отношениях в соответствии с требованиями Конвенции ООН о правах ребёнка»[21].

Конституция РФ закрепляет фундаментальные права детей как уязвимой категории граждан. Статья 7 провозглашает Россию социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Статьи 38 и 39 устанавливают, что «материнство, детство и семья находятся под защитой государства; забота о детях и их воспитание — равное право и обязанность родителей; гарантируется социальное обеспечение для воспитания детей»[4]. Статья 40 гарантирует право на жилище, защищая детей от произвольного лишения крова[4].

Основу отраслевого регулирования составляют следующие нормативные правовые акты. Семейный кодекс РФ определяет правовой статус ребёнка, порядок осуществления родительских прав, формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей (усыновление, опека,

попечительство), а также алиментные обязательства. В кодексе выделена специальная глава о правах несовершеннолетних. «Ребёнку предоставлено право выражать своё мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также при судебном и административном разбирательстве»[21]. В духе Конвенции решён вопрос о праве ребёнка на защиту от злоупотреблений родителей или лиц, их заменяющих, вплоть до обращения несовершеннолетнего в суд по достижении им возраста 14 лет.

Базовым актом выступает Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», определяющий «государственную политику в интересах детей»[1] и гарантирующий бесплатную медицинскую помощь, включая диспансеризацию и реабилитацию. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ закрепляет основы «системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»[6]. Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ устанавливает «дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»[10] в сферах образования, жилья и трудоустройства. Смежные акты об образовании, охране здоровья и пособиях семьям, а также нормы Трудового кодекса о труде несовершеннолетних, дополняют эту рамку[9][3].

Важную роль играют указы Президента и постановления Правительства — от программы «Дети России» и национальных стратегий действий в интересах детей до стандартов социальных услуг и порядка выплат пособий[2][5]. Субъекты РФ вправе устанавливать дополнительные меры поддержки за счёт региональных бюджетов.

Система охватывает здравоохранение, образование, социальную поддержку и защиту от вредоносной информации. Как отмечает Е. И. Холостова, направления «системы социальной защиты детства» определяются уровнем материального обеспечения детей, международными обязательствами России и отечественным историческим опытом защиты детства[59][76].

Система социальной защиты детства — это «интегрированная совокупность основных направлений и принципов, субъектов и объектов, форм, методов и материальной базы национальной защиты российских детей»[59]. В 1990-е гг. в результате проведения реформ в России проблемы социальной защиты детства значительно обострились. Основными причинами этого явились фактическое общее снижение роли государства в системе социальной защиты детства, ослабление роли профсоюзов и общественных детских организаций и отсутствие какой-либо альтернативы им, значительное снижение общего жизненного уровня населения России, серьёзное сокращение государственных расходов на содержание, обучение и воспитание детей. А. М. Панов отмечает: «кризис 1990-х годов показал необходимость восстановления государственных гарантий в сфере защиты семьи и детства и развития профессиональной социальной работы»[60]. Е. М. Рыбинский подчёркивает: «социальная защита детства должна опираться на приоритет интересов ребёнка и на ответственность государства за создание условий для его развития»[81].

Вместе с тем состояние социально-правовой защиты детства не во всех аспектах соответствует требованиям Конвенции: сохраняются трудности в реализации права ребёнка «на уровень жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития»[8], а также в информировании о положениях Конвенции и в охране здоровья детей.

Объект социальной защиты — все дети по общим проблемам их правового положения, материального обеспечения, образования, здравоохранения, нравственного и физического развития и досуга. Субъект социальной защиты — государство и создаваемые им институты, политические партии и общественные организации, церковь, средства массовой информации, семья, школа, другие детские учреждения. М. А. Галагузова пишет: «субъекты социальной работы с детьми включают государственные органы, учреждения социального обслуживания,

образовательные организации и общественные объединения, действующие в интересах ребёнка»[74].

Цели государственной политики в области защиты детей — обеспечение конституционных прав, содействие разностороннему развитию и реализация личности ребёнка. В основу положены «законодательное обеспечение прав и интересов ребёнка» и «государственная поддержка семьи»[1] при соблюдении минимальных социальных стандартов[59].

Неотъемлемыми факторами любой нормально функционирующей социальной системы являются социальная защита и социально-экономическая поддержка населения. Социальная защита — стратегия государственной политики по поддержке и защите наиболее незащищённых слоёв населения — детей, женщин, стариков; система гарантированных государством экономических, организационных, правовых мер, обеспечивающих гражданам условия для преодоления трудной жизненной ситуации. В широком смысле слова социальная защита — это политика государства по обеспечению конституционных прав и минимальных гарантий человеку независимо от его места жительства, пола, возраста, национальности. «Главная цель социальной защиты — оказание необходимой помощи конкретному человеку (ребёнку) в сложной жизненной ситуации»[50]. Л. В. Топчий отмечает: «эффективность социальной защиты детства определяется согласованностью действий органов власти, учреждений и семьи при приоритете интересов ребёнка»[76].

В настоящее время политика государства в области социальной защиты детства проявилась в выплате ежемесячных пособий, в создании новых учреждений защиты семьи и детства, в обеспечении государственных гарантий в области образования. В. П. Мельников и Е. И. Холостова в истории социальной работы показывают, что «становление системы помощи детям-сиротам и иным уязвимым группам населения шло от благотворительных практик к государственно-правовому регулированию социальной защиты»[45].

Проблема социально-психологической помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, требует объединения усилий социальных работников, психологов и педагогов в разработке индивидуальных методик работы с каждым ребёнком, оказавшимся в детском доме, приюте, социальной гостинице, после интерната. Н. М. Платонова подчёркивает: «постинтернатное сопровождение должно обеспечивать непрерывность поддержки выпускника при переходе к самостоятельной жизни»[52]. П. Я. Циткилов добавляет: «технология социальной работы с воспитанником после интерната включает диагностику ресурсов, сопровождение и контроль адаптации»[56]. Е. И. Холостова отмечает: «успех постинтернатной адаптации зависит от согласованности действий специалиста, семьи и учреждений социальной защиты»[59].

1.2 Профессиональный портрет и функции специалиста по социальной работе

Специалист по социальной работе — это квалифицированный работник, чья деятельность направлена на поддержку людей и групп, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. По смыслу отечественных подходов «его задача заключается в содействии улучшению их социального положения и расширении ресурсов для самообеспечения»[30]. Эффективность такой работы, как отмечают исследователи, «обусловлена интеграцией теоретических знаний, практического опыта и личностных компетенций»[31]. В работах Е. И. Холостовой подчёркивается, что «профессиональная помощь в социальной сфере невозможна без сочетания нормативной грамотности, умения выстраивать контакт и готовности нести ответственность за последствия вмешательства»[59].

Квалификационные требования к специалисту включают среднее профессиональное образование, высшее образование по профилю либо непрофильное высшее образование с дополнительной профессиональной переподготовкой[34]. При работе с несовершеннолетними обязательны «отсутствие судимости и прохождение обязательных медицинских

осмотров»[35]. Эти условия задают формальный порог допуска, однако сами по себе не определяют качество помощи. Как пишет А. М. Панов, «профессионализм в социальной работе проявляется не в формальном соответствии должности, а в способности видеть человека в его жизненной ситуации и действовать в интересах его благополучия»[60].

В структуре личностных качеств и компетенций обычно выделяют эмпатию и коммуникабельность, эмоциональную устойчивость, тактичность, доброжелательность, ответственность, проблемно-ориентированное мышление и организационные навыки. Как фиксируется в описаниях профессиограммы, «доброжелательность и гуманистическая направленность предполагают желание помогать людям, не осуждая»[36], а ответственность и объективность — способность беспристрастно оценивать ситуацию и принимать решения[37]. «Эмпатия и коммуникабельность — умение сопереживать, слушать, устанавливать доверительный контакт»[32]. Эмоциональная устойчивость и стрессоустойчивость — способность сохранять работоспособность в эмоционально напряжённых ситуациях[33]. «Тактичность и деликатность — умение корректно общаться, соблюдая конфиденциальность»[34]. Л. С. Алексеева отмечает, что при работе с детьми, оставшимися без попечения родителей, особенно важны «уважение к личности ребёнка и отказ от осуждающей позиции по отношению к его семье»[61]. В. С. Мухина связывает успешность сопровождения с «чувствительностью к внутреннему миру ребёнка и к особенностям его самосознания»[62].

Согласно профессиональным стандартам, деятельность специалиста включает «диагностику нужды, индивидуальное планирование, организацию и реализацию помощи, целевое сопровождение»[35]. Первоочередная задача — «выявить, какие именно жизненные обстоятельства ухудшают положение человека и в какой социальной поддержке он нуждается»[35]. На основе диагностики разрабатывается «персонализированный план предоставления

социальных услуг»[36]; далее специалист координирует своевременную реализацию мер[37].

Практически работа разворачивается через «приём и первичную консультацию граждан», «сбор информации через беседы и анализ документов», «оценку реальных условий жизни клиента» и «систематизацию данных о проблемах клиента»[38]. Важны также «взаимодействие с людьми из окружения клиента», «подготовка документов для оформления услуг», «помощь в мобилизации внутренних и внешних ресурсов» и «направление к узким специалистам или в профильные учреждения»[39]. Дополнительно специалист осуществляет «разработку и проведение профилактических мероприятий», выполняет «роль связующего звена между клиентом и различными организациями», обеспечивает «координацию работы междисциплинарных команд» и «анализ эффективности работы»[40]. М. К. Бардышевская подчёркивает: «формальное выполнение мер без учёта эмоционального состояния ребёнка быстро обесценивает даже правильно составленный план»[63]. Сходную мысль формулирует Т. В. Сафонова: «ведение случая требует не только алгоритма действий, но и постоянного соотнесения помощи с актуальными переживаниями и ресурсами ребёнка»[64].

Профессия социального работника характеризуется высокой степенью ответственности и сложности, что обусловлено многогранностью решаемых задач и необходимостью соблюдения строгих этических принципов[41]. «Совокупность квалификационных, психологических и личностных характеристик специалиста формирует его профессиональный портрет, который в научной среде принято называть профессиограммой»[42]. В структуре профессионального портрета выделяют три ключевых блока: теоретическую базу, практические умения и личностные качества[38]. Фундаментом выступает междисциплинарная подготовка — социология, психология, педагогика, право[39]; работа с девиантным поведением требует также знаний криминологии[43]. Взаимодействие с уязвимыми категориями

населения «требует понимания специфики их жизненных ситуаций и владения методами психодиагностики»[40].

Кроме того, специалист должен обладать широким гуманитарным кругозором. Понимание социальной структуры общества, политических и экономических процессов, а также культурных особенностей различных субкультур необходимо для эффективной адаптации и поддержки клиентов[41]. «Фундаментальная подготовка в области философии, истории, политологии и культурологии формирует необходимый уровень социальной компетентности специалиста»[44]. М. В. Фирсов указывает, что «социальная работа как профессия опирается на гуманистические ценности и одновременно требует технологической дисциплинированности»[65]. Л. В. Топчий отмечает: «профессиональная культура специалиста складывается там, где знание нормы соединяется с умением действовать в неопределённой ситуации клиента»[66].

Компетентность социального работника базируется на интеграции теории и практики. Фундаментальная подготовка специалиста включает гуманитарный блок, позволяющий глубоко анализировать потребности и ценностные ориентиры различных социальных групп, а также медико-психологические знания, необходимые для сопровождения лиц с особенностями здоровья[45]. Практическая составляющая профессионального портрета охватывает широкий спектр умений: от оказания первичной помощи до квалифицированного консультирования[42]. Особое место занимают коммуникативные технологии, направленные на установление терапевтического контакта и организацию совместной работы над проблемами клиента[43]. «Важным аспектом подготовки является овладение методами психологической саморегуляции, предотвращающими профессиональное выгорание»[46]. Н. Ф. Басов и Е. И. Холостова сходятся в том, что «без регулярной рефлексии практики специалист быстро утрачивает чувствительность к клиенту и скатывается к шаблонным решениям»[67].

Современная система подготовки социальных работников предусматривает прохождение различных видов практики, направленных на формирование профессиональных компетенций еще на этапе обучения[47]. Тем не менее «текущий объём практической подготовки и качество её организации требуют существенной доработки»[44]. Ключевым вектором развития должно стать укрепление партнерства между образовательными организациями и профильными социальными службами[48]. Г. А. Галагузова пишет, что «социально-педагогическая подготовка специалиста эффективна лишь тогда, когда учебные знания постоянно проверяются реальной работой с ребёнком и семьёй»[68]. М. А. Галагузова дополняет: «практика формирует не только навыки, но и профессиональную позицию — готовность быть рядом с человеком в кризисе»[69].

Особую роль в профессиональном профиле социального работника играют личностные качества[49]. «Специфика данной сферы, предполагающая работу с уязвимыми категориями граждан, исключает формальный подход, ориентированный исключительно на отчетность»[50]. Подобная деформация профессиональной этики неизбежно ведет к негативным последствиям для подопечных[45]. «Отсутствие эмпатии и ответственности у специалиста в сочетании с беспомощностью клиента создает условия для грубых нарушений профессиональных обязанностей»[46]. Отсутствие развитых морально-нравственных характеристик снижает эффективность работы и фактически означает профессиональную непригодность[47]; личностные качества остаются неотъемлемым компонентом профессионализма[52]. И. Ф. Дементьева подчёркивает, что в работе с детьми-сиротами «нравственная зрелость специалиста не менее значима, чем его методическая оснащённость»[70].



Рисунок 1 – Структура социально-педагогической технологии

Структура, то есть способ связи основных элементов явления, помогает понять, из чего оно состоит. Каждый такой элемент называют компонентом. Социально-педагогическая технология — это целенаправленный и продуманный порядок действий[53]. «Обычно она включает в себя несколько этапов, которые вместе ведут к достижению намеченной цели»[54]. Чаще всего выделяют три ключевых этапа: подготовка, сама реализация технологии и оценка результатов[48]. «Иногда подготовительный этап разделяют на два: анализ ситуации и планирование, а затем непосредственную подготовку»[55]. При рассмотрении типичной социально-педагогической технологии важно выделить: ее главную цель, то, на что она направлена, и то, с чем предстоит работать[56]. Любая социально-педагогическая технология имеет свою цель, задачи и соответствующее им содержание[49]. Именно цель определяет назначение технологии — общее или более конкретное. В. Н. Гуслова отмечает, что «технология в социальной работе не подменяет живое общение, а упорядочивает его так, чтобы помощь не рассыпалась на разрозненные действия»[71].

Устройство универсальной социально-педагогической методики обычно описывают через пять последовательных шагов. Первый — анализ и

предвидение: «на этом начальном этапе происходит изучение ситуации клиента, выявление его трудностей в социальной и воспитательной сферах, а также прогнозирование возможных путей развития и изменений»[57]. Главная задача прогноза — определить сильные стороны клиента, которые помогут ему справиться с возникшими проблемами[50]. «Этот этап служит для сбора всей необходимой информации, которая понадобится специалисту для дальнейшей работы»[58]. Второй шаг — выбор или создание подходящего подхода. Имея полное представление о клиенте и его проблемах, специалист определяет конкретную цель взаимодействия и подбирает соответствующую методику[59]. Такая методика должна максимально способствовать достижению поставленной цели, поэтому ее часто называют целевой[60]. На этом этапе возможны три варианта: «выбрать уже существующую методику, подходящую для данного случая»; «адаптировать существующую методику, учитывая особенности клиента, его жизненные обстоятельства и возможности специалистов»; «создать совершенно новую, индивидуальную методику, отвечающую уникальным потребностям клиента»[61]. Третий шаг — подготовка к практическому применению: «этот этап посвящен детальной проработке всех необходимых условий для успешного внедрения выбранной методики»[62]. Сюда входят вопросы обеспечения материальными ресурсами, технической поддержки, организационных моментов и подбора соответствующих инструментов и материалов[63]. Такая подготовка помогает заранее выявить и устранить возможные препятствия, гарантируя высокое качество и результативность всей дальнейшей работы с клиентом[51]. Четвёртый шаг — практическая реализация: здесь происходит непосредственное применение выбранной и подготовленной методики в работе с клиентом[64]. Пятый — оценка результатов: «завершающий этап, на котором анализируется эффективность примененной социально-педагогической методики и оцениваются достигнутые результаты всей проделанной работы»[65]. Г. В. Семья показывает, что «этап оценки часто остаётся слабым звеном, если критерии

результата заранее не согласованы с ребёнком и его ближайшим окружением»[72].

Частные социально-педагогические технологии базируются на принципах общих технологий, однако обладают специфической внутренней структурой[66]. «Каждая из них включает уникальные этапы, отражающие конкретное содержание и методы реализации поставленных задач»[67]. Эти этапы можно рассматривать как детализированные подструктуры общего технологического процесса[68].

Структура диагностико-прогностической технологии включает два ключевых этапа. «Диагностический этап. Его цель — комплексное изучение личности клиента»[69]. В процессе диагностики анализируются «характер отклонений в развитии и сопутствующие социальные трудности»; «физическое состояние и здоровье»; «личностный потенциал и ресурсы, на которые можно опереться в работе»; «субъективная позиция клиента: его мотивация, активность, готовность к саморазвитию и характер взаимодействия с педагогом»; «влияние микросоциальной среды»[70]. «Учитывая сложность проблем, диагностика часто носит междисциплинарный характер»[52]. Привлечение узких специалистов позволяет получить объективную картину состояния клиента[71]. Итогом такой работы становится разработка стратегии сопровождения, включающей конкретные рекомендации, показания и предостережения для выстраивания эффективного взаимодействия с клиентом и его окружением[72]. А. М. Прихожан и Н. Н. Толстых отмечают, что у детей вне семьи «диагностическая картина должна учитывать последствия депривации и особенности формирования привязанности»[73]. В. Н. Ослон подчёркивает: «диагностика без последующего включённого сопровождения остаётся описанием дефицитов, а не инструментом помощи»[74].

Процесс диагностики в работе социального педагога обычно состоит из «первичного анализа: изучения сведений, полученных при первом контакте с клиентом»; «целеполагания: определения объекта и содержания

предстоящего исследования»; «подготовки: организационной и методической настройки диагностического процесса»; «проведения диагностики»; «интерпретации: обработки данных и постановки социально-педагогического диагноза»[73]. На этом этапе педагог выявляет индивидуальные особенности клиента и формулирует одну или несколько социально-педагогических проблем[53]. Чёткое понимание этих проблем служит основанием для перехода к прогностическому этапу. «Опираясь на результаты диагностики, социальный педагог моделирует дальнейший ход работы»[74]. Прогнозирование позволяет определить «вектор и динамику развития клиента»; «потенциал личности в целом или в отдельных сферах»; «зону ближайшего развития — конкретные цели для ближайшего этапа работы»; «условия, необходимые для эффективного воспитательного процесса»[75]. Алгоритм прогностической деятельности включает осмысление диагностических данных, определение целей и методов прогнозирования, техническую и методическую подготовку, разработку прогноза, анализ полученного прогноза и подведение итогов. Л. Я. Олиференко связывает качество прогноза с «умением видеть не только риски, но и опорные точки роста ребёнка в конкретной среде»[75].

«Ключевой задачей социального педагога является подбор наиболее эффективных методов работы, соответствующих конкретному случаю и внешним условиям»[76]. В зависимости от уровня профессионализма и специфики ситуации специалист может использовать готовые технологии, адаптировать их под нужды клиента или разработать авторскую методику[77]. «Процесс выбора и подготовки социально-педагогической технологии включает два ключевых блока этапов»[78].

Первый блок — выбор оптимальной технологии. Он начинается с «диагностики: изучения исходных данных и социально-педагогических проблем клиента», затем следует целеполагание: определение желаемого результата и постановка конкретных задач[79]. Далее идёт «моделирование: мысленное проектирование процесса, сравнение различных подходов для

поиска наиболее эффективного решения», затем «отбор: фиксация целевой технологии» и «оценка пригодности: сопоставление модели с ресурсами и прогнозирование возможных рисков»[80]. После этого следует «принятие решения: окончательный вывод о соответствии выбранного метода текущей ситуации» и «определение способа реализации»[81]. Второй блок — подготовка к реализации технологии: «анализ ресурсов», «планирование задач», «организационно-техническое обеспечение», «апробация» и «календарное планирование»[82]. М. И. Никитина пишет, что «выбор технологии должен подчиняться интересам ребёнка, а не удобству отчётной формы»[76]. С. А. Беличева добавляет: «эффективность вмешательства растёт, когда специалист способен гибко менять инструменты по мере изменения ситуации семьи»[77].

Организационно-деятельностный компонент социально-педагогической технологии является ключевым звеном социально-педагогического процесса, определяющим результативность всей профессиональной деятельности специалиста[83]. Практическая реализация технологии структурируется следующим образом. Этап адаптации и установления контакта предполагает взаимную настройку субъекта и объекта деятельности. Успешность формирования доверительных отношений и взаимопонимания напрямую влияет на эффективность дальнейшей работы[54]. Особую сложность этот этап представляет при взаимодействии с детьми, имеющими девиантное поведение, а также нарушения в интеллектуальной или эмоционально-волевой сферах. «Этап вовлечения в процессы саморазвития предполагает индивидуально-дифференцированный подход, при котором объект постепенно включается в работу над собственным воспитанием и личностным ростом»[84]. Этап мониторинга и рефлексии позволяет оценить промежуточную эффективность применяемых методов и при необходимости скорректировать стратегию достижения цели[85]. «Итоговый этап включает анализ достигнутых результатов и сопоставление их с первоначально поставленными задачами для оценки

качества проделанной работы»[86]. И. А. Бобылева отмечает, что «устойчивый контакт со взрослым значимым лицом часто оказывается условием, без которого любые коррекционные процедуры остаются поверхностными»[78]. Т. И. Шульга подчёркивает роль специалиста как «посредника между ребёнком и социальными институтами на всём протяжении сопровождения»[79].

Механизм экспертно-оценочной социально-педагогической технологии базируется на анализе итогов соответствующей деятельности[87]. Оценка представляет собой смешанную качественную и количественную характеристику реализации отдельных этапов, методов или средств[88]. Для измерения любых явлений требуется наличие четких критериев и индикаторов[55]. «В роли критериев обычно выступают целевые ориентиры, а в качестве показателей — уровень достижения этих целей»[89]. Экспертиза подразумевает сравнение оцениваемого явления с установленным эталоном[90]. «Подобную работу выполняют опытные специалисты, поскольку оценка носит субъективный характер; для повышения ее объективности часто привлекают группу экспертов»[30]. Эталонным результатом служит показатель, неоднократно достигнутый при использовании технологии[31]. Экспертно-оценочная деятельность рассматривается и как самостоятельная технология, и как финальный этап общей[33]. «Каждая из этих форм имеет собственные задачи, структуру и содержание»[34].

Любая технология требует базовых вводных данных, создающих предпосылки для внедрения. «К таким параметрам относятся: наличие целевого объекта и предмета деятельности; информация о субъекте; данные, необходимые для аналитической работы при принятии решений о методах практической реализации; а также конкретные условия проведения процесса»[35]. Структура стандартной социально-педагогической технологии включает несколько ключевых этапов[36]: информационно-аналитическую фазу, этап выбора оптимального способа преодоления

проблемы, прикладную стадию и завершающий экспертно-оценочный этап. «Информационно-аналитическая фаза предполагает обработку входящих сведений, осмысление исходных материалов и четкое определение решаемой проблемы»[37]. Типовая технология демонстрирует, что независимо от специфики содержания последовательность действий специалиста обладает общими чертами, что упрощает освоение механизма практической работы[57]. При этом каждый отдельный этап имеет собственное смысловое наполнение и особенности реализации. Е. И. Холостова формулирует это как необходимость «единого логического каркаса помощи при сохранении индивидуализации содержания»[80].

Подготовка кадров требует комплексного подхода: от профориентации и отбора абитуриентов до непрерывного образования и оценки компетенций при трудоустройстве[38][39]. Эффективность служб зависит от контроля исполнения обязанностей и мотивации сотрудников[58]. «Важнейшим условием профессионального роста является непрерывное обучение, доступное сегодня в вузах»[40]. А. В. Мудрик указывает, что профессиональное становление специалиста социальной сферы «не завершается дипломом, а продолжается как постоянное уточнение позиции во взаимодействии с людьми»[81].

Профессионально важные качества специалиста принято делить на три группы. Индивидуальные качества включают когнитивные способности и эмоциональную устойчивость[42]. Личностные качества включают ответственность, честность и умение объективно оценивать себя[43]. Профессиональные качества включают навыки общения, эмпатию и умение расположить к себе клиента[44]. Помимо базовых характеристик целесообразно рассматривать узкопрофильные компетенции. «Возникает методологическая дилемма: как сочетать универсальную подготовку специалиста с необходимостью глубоких знаний в конкретных областях, избегая при этом крайностей — чрезмерного упрощения или оторванного от практики теоретизирования»[45]. Оптимальное решение заключается в

переходе к специализации нового формата, где фокус внимания смещается с отдельной социальной проблемы на целостную личность клиента, обладающего совокупностью взаимосвязанных трудностей[46]. «Такой подход позволяет рассматривать трудную жизненную ситуацию клиента как единое целое»[82]. Социальная работа выступает инструментом комплексного решения проблем, избегая их искусственного дробления на экономические, медицинские или психологические аспекты, которые обычно распределяются между разными ведомствами[47]. «Это позволяет сохранить междисциплинарный характер деятельности, наполняя его при этом прикладным содержанием»[48]. Г. В. Семья отмечает, что «целостный взгляд на ребёнка и его сеть отношений даёт шанс выйти за пределы ведомственной фрагментарности»[83].

Интегративный характер социальной работы обусловливает ключевые профессиональные функции специалиста. Диагностическая функция связана с выявлением глубинных причин возникновения проблем клиента[49]. «Адвокативная — с представлением и отстаиванием интересов клиента в различных инстанциях»[50]. Социально-терапевтическая функция предполагает оказание прямой поддержки и предоставление необходимых социальных услуг[51]. «Социально-профилактическая направлена на предотвращение кризисных ситуаций»[52]. Прогностическая — на моделирование возможных изменений в поведении клиента[53]. «Проективная — на стратегическое и тактическое планирование результатов вмешательства»[54]. Контрольная включает мониторинг девиантного поведения и применение мер социального воздействия[55]. Организационно-административная — координацию взаимодействия с другими социальными институтами и управленческую деятельность[56]. П. Д. Павленок и Е. И. Холостова показывают, что «эти направления не существуют изолированно: в реальной практике они переплетаются в одном ведении случая»[84].

В международной практике профессиональные роли социального работника принято классифицировать исходя из специфики выполняемых

задач. Брокер выступает связующим звеном, помогая клиенту ориентироваться в системе социальных служб и получать доступ к нужным ресурсам[57]. «Посредник помогает разрешать конфликты и выстраивать конструктивное взаимодействие между сторонами»[58]. Адвокат борется за права и достоинство клиентов, инициируя изменения в законодательстве или практике обслуживания в интересах уязвимых групп[59]. «Оцениватель занимается сбором и анализом данных о проблемах клиента для принятия обоснованных решений»[60]. Мобилизатор активизирует ресурсы отдельных лиц или групп, организуя их для совместного решения актуальных задач[61]. Учитель транслирует знания и навыки, необходимые клиенту для самостоятельного преодоления трудностей[62]. М. В. Фирсов отмечает, что «освоение этих ролей в отечественной практике идёт через адаптацию международного опыта к российским институциональным условиям»[85]. Формирование профессиональной идентичности — длительный процесс, стартующий ещё до трудовой деятельности[63]. «Ключевыми факторами здесь выступают как исходный потенциал абитуриентов, так и уровень университетского образования, совершенствование которого возможно через внедрение многоуровневой системы подготовки»[64].



Рисунок 2 – Работа по профилактике социального сиротства

Комплекс мер по предотвращению социального сиротства охватывает несколько направлений. Это «обеспечение стабильности социально-экономических и политических процессов в государстве»; «восстановление духовных ценностей национальной культуры»; «предоставление всесторонней поддержки семье, материнству и детству через экономические, правовые и социальные механизмы»; «возрождение и продвижение гуманистических воспитательных традиций, основанных на любви и уважении к ребенку»; «трансформация деятельности интернатных учреждений для сирот»; «улучшение механизмов устройства детей-сирот в семьи»[65]. «В настоящее время государство выделяет колоссальные финансовые ресурсы на содержание детей-сирот, создавая новые государственные структуры, общественные организации и фонды»[86]. Однако такие действия не решают коренную проблему, если остаются на уровне реагирования на последствия[87]. И. Ф. Дементьева и Л. С. Алексеева подчёркивают, что «профилактика должна начинаться с поддержки семьи до момента утраты ребёнком родительского попечения»[88].

Анализ мирового опыта показывает, что эффективная профилактика социального сиротства требует комплексного подхода на всех уровнях государственного и общественного управления[66]. Эти меры варьируются от масштабной социальной политики, направленной на общество в целом, до селективных действий в отношении конкретных социальных групп[67]. «Кроме того, необходимы индивидуальные программы поддержки женщин, оказавшихся в кризисной ситуации и находящихся под угрозой отказа от материнства»[68]. Глобальная стратегия предотвращения социального сиротства охватывает все аспекты государственной социальной политики[69]. «Фундаментальными условиями для решения этой проблемы выступают ликвидация бедности, устранение любых форм социальной незащищенности, повышение качества жизни граждан и адресная поддержка многодетных и молодых семей»[70]. Особое место занимает формирование родительских компетенций[71]; подготовка к родительству требует более

глубокого подхода, чем одно лишь просвещение[72]. Г. В. Семья указывает, что «родительская компетентность формируется через опыт заботы, поддержку близких и доступность служб ранней помощи»[89].

Важнейшим инструментом профилактики отказа от детей является работа с группами повышенного риска, среди которых выделяются женские кризисные центры[73]. «Шведская модель таких учреждений, функционирующих как закрытые или полузакрытые организации, гарантирует полную безопасность для женщин, прибывших туда вместе с детьми или самостоятельно»[74]. «Круглосуточная линия доверия, обслуживаемая специалистами, доступна посетителям на протяжении четырех месяцев»[76]; команда специалистов помогает снизить стресс и восстановить социальные связи[77]. Программа часто реализуется в два этапа: превентивная поддержка будущих матерей и экстренная работа в родильных домах[78][79]. В. Н. Ослон отмечает, что «сочетание раннего выявления кризиса беременности и последующего сопровождения семьи существенно снижает вероятность отказа от ребёнка»[90].

«Сегодня одной из наиболее острых и общественно значимых задач выступает поиск эффективных механизмов снижения уровня детской беспризорности и безнадзорности, а также минимизация явлений социального сиротства»[80]. Профилактические меры необходимы всем слоям населения, но в особой степени они затрагивают категории повышенного риска[81]. «Профилактика выступает ключевым и перспективным направлением в социальной работе по устранению проблем социального сиротства»[82]. Своевременные превентивные действия сокращают затраты на работу с уже сформировавшимися отклонениями[83]. Первичная профилактика требует интеграции усилий разных систем[30] и создаёт базу для педагогической, психологической и медицинской профилактики.

Работа по предотвращению социального сиротства реализуется через три основных направления. Общесоциальный уровень охватывает действия

государства и общественных институтов, направленные на устранение экономических, социальных и духовных противоречий[84]. «Специальный уровень подразумевает целенаправленное воздействие на негативные факторы, вызывающие отдельные виды девиаций или проблем»[85]. Индивидуальный уровень фокусируется на работе с конкретными личностями, чье поведение демонстрирует признаки отклонений[86]. «Первичная профилактика представляет собой совокупность мер, призванных нейтрализовать биологические и социально-психологические риски, способствующие формированию нежелательного поведения»[87]. Именно своевременность, непрерывность и полнота этого этапа считаются ключевыми для предотвращения отклонений у детей и подростков[31]. Вторичная профилактика включает медицинские, юридические и психологические меры, применяемые к несовершеннолетним, уже проявляющим девиантное или асоциальное поведение[88]. Главная задача здесь — не допустить эскалации проступков до уровня серьезных правонарушений или преступлений[89]. «Третичная профилактика направлена на предотвращение рецидивов среди подростков, покинувших специализированные учреждения»[90]. Она носит социально-психологический и правовой характер и нацелена на успешную социальную реабилитацию бывших воспитанников[30]. «С. А. Беличева связывает эти уровни в единую логику: чем раньше начинается работа, тем меньше вероятность, что вмешательство сведётся к контролю уже совершённых нарушений»[77].

Исходя из изложенного, «под профилактикой следует понимать научно обоснованные и своевременно реализуемые меры»[31], направленные на предотвращение, устранение или нейтрализацию ключевых причин и условий, провоцирующих социально негативные отклонения[32]; на «недопущение возможных физических, психических и социокультурных девиаций среди различных индивидов и социальных групп»[33]; «на сохранение, поддержку и защиту нормального уровня жизни и здоровья

людей, а также содействие в достижении поставленных целей и раскрытии их внутреннего потенциала»[34]. «Эффективность социальной профилактики во многом зависит от профессионализма субъекта воздействия и комплексного характера применяемых мер»[32]. «Социальная профилактика формирует предпосылки для нормальной социализации личности, основанной на приоритете принципов законности и морали, тем самым закладывая фундамент благополучия семей и социальной стабильности общества в целом»[35]. «Профилактика семейного неблагополучия как фактора социального сиротства является одним из важнейших видов профилактики, используемых в практике социальной работы»[36]. «Различные источники выделяют два этапа профилактической работы. Первый связан с выявлением несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В процессе профилактики должна быть обеспечена полнота выявления профилактируемого контингента»[33]. «Это будет возможно лишь в том случае, если в данном процессе будут участвовать все обозначенные в законе субъекты профилактики»[37]. «Важно, чтобы в этом процессе принимали участие органы и учреждения, которые работают с семьей на ранних этапах формирования личности несовершеннолетнего, — учреждения социальной защиты населения и здравоохранения, дошкольные и школьные образовательные учреждения»[38].

В соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, индивидуальная профилактическая деятельность осуществляется как с самими подростками, так и с их семьями, оказавшимися в сложных жизненных обстоятельствах[39]. «Для каждой из этих категорий разрабатываются специализированные программы, содержащие мероприятия, адаптированные под индивидуальные особенности каждого профилактируемого субъекта»[40]. «Успешность данного процесса во многом определяется глубиной изучения личности

подростка: необходимо тщательно проанализировать его отношение к учебе, родителям и труду, оценить физическое и психическое здоровье, а также выявить характер отклоняющегося поведения и причины, его вызвавшие»[41]. Н. Ф. Плясова подчёркивает: «социальная работа с детьми, оставшимися без попечения родителей, должна строиться на индивидуальном изучении личности ребёнка и семьи как условии эффективной профилактики»[65].

На основе сказанного можно подчеркнуть несколько положений. «Профилактика социального сиротства является актуальной необходимостью; она требует комплексной организации работы на конкретной территории, охватывающей весь контингент несовершеннолетних и их семей»[42]. «Данная профилактика представляет собой систему мер, направленных на изучение и прогнозирование безнадзорности, беспризорности и социального сиротства, с целью нейтрализации негативных факторов, влияющих на формирование и развитие личности подростков»[43]. Е. И. Холостова пишет: «профилактика социального сиротства эффективна лишь при сочетании раннего выявления семейного неблагополучия и адресной работы социальных служб»[59]. Л. С. Алексеева добавляет: «социальная работа с семьёй в учреждениях социального обслуживания должна предупреждать утрату ребёнком родительского попечения»[61].

Понятие «социальное образование» трактуется двояко. В широком смысле — это «интеграция социально-гуманитарных знаний в образовательный процесс на всех этапах, что способствует повышению гражданской компетентности и социальной грамотности населения»[45]. В узком смысле — это «профессиональная подготовка кадров для социальной сферы»[46]. «Оба направления критически важны: узкоспециализированное образование обеспечивает качественную работу социальных служб, а широкое — формирует здоровую социальную среду, повышая уровень правовой культуры, толерантности и снижая уровень общественной

напряженности»[47]. М. В. Фирсов отмечает: «социальное образование формирует профессиональную идентичность специалиста и обеспечивает связь теории социальной работы с практикой помощи»[75].

Выводы по главе 1

Анализ теоретических основ деятельности специалиста по социальной работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, позволяет зафиксировать несколько взаимосвязанных положений.

Во-первых, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, выступают особым объектом социальной работы. Сиротство как социальное явление включает не только утрату родителей вследствие смерти, но и широкий круг ситуаций, когда родители фактически не осуществляют заботу о ребёнке. Наиболее острым проявлением современной картины остаётся социальное сиротство: как отмечает П. Я. Циткилов, «социальное сиротство в современной России носит преимущественно социальный, а не биологический характер, что требует переноса акцента на работу с кровной семьёй»[56]. Исследования показывают, что воспитание вне семьи и длительная депривация существенно влияют на развитие ребёнка: по данным И. В. Дубровиной, «особенности психического развития детей вне семьи требуют специальной коррекционной работы»[36], а Л. М. Шипицына фиксирует, что «наибольшие трудности и отклонения от нормального становления личности наблюдаются в эмоционально-волевой сфере, нарушении социального взаимодействия, неуверенности в себе»[58]. Поэтому государственная политика в данной сфере должна сочетать профилактику социального сиротства с развитием системы защиты и сопровождения детей, уже оставшихся без родительского попечения.

Во-вторых, нормативно-правовая база защиты детства задаёт рамки профессиональной деятельности специалиста. Международные документы о правах ребёнка, федеральные законы о «дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»[10], об опеке и попечительстве, об основах системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также региональные акты формируют требования к содержанию помощи, к межведомственному взаимодействию и к приоритету семейных форм устройства. Как подчёркивает Е. И. Холостова, «государственная политика в отношении детей-сирот должна сочетать предупреждение социального сиротства с созданием условий для полноценного устройства и воспитания ребёнка, утратившего семейную заботу»[59]. Вместе с тем наличие правовых гарантий не снимает проблему качества их реализации: эффективность помощи зависит от того, насколько последовательно специалист переводит норму в конкретное сопровождение ребёнка и семьи.

В-третьих, профессиональный портрет специалиста по социальной работе включает теоретическую подготовку, практические умения и личностные качества. Междисциплинарные знания в области психологии, педагогики, права и социологии соединяются с навыками диагностики, планирования, организации помощи и оценки результатов. Особое значение имеют эмпатия, ответственность, эмоциональная устойчивость и готовность к ведению случая без формального сведения работы к отчётности. По сути, «технология социальной работы требует не только нормативной грамотности, но и устойчивых навыков межведомственной координации»[56], а «социальная работа должна соединять правовую защиту, психологическую помощь и организацию жизненной среды ребёнка»[59]. Функции специалиста — диагностическая, адвокативная, социально-терапевтическая, профилактическая, прогностическая, проективная, контрольная и организационно-административная — в практике не существуют изолированно и реализуются в единой логике сопровождения.

В-четвёртых, социально-педагогические технологии задают упорядоченную последовательность действий: от анализа ситуации и прогноза к выбору или адаптации метода, подготовке условий, практической реализации и экспертной оценке. Для работы с детьми-сиротами принципиальны диагностико-прогностический этап, установление

доверительного контакта, вовлечение ребёнка в процессы саморазвития и постоянный мониторинг изменений. Профилактика социального сиротства при этом выступает не дополнением, а необходимым направлением: «приоритетом социальной политики выступает сохранение ребёнка в кровной семье и, при невозможности этого, устройство в замещающую семью»[59], а «замещающая семья и наставничество способны компенсировать дефицит привязанности, если сопровождение носит длительный и профессионально организованный характер»[71].

Таким образом, теоретический анализ показывает: объектом профессиональной деятельности выступает ребёнок в ситуации утраты или угрозы утраты родительского попечения, а содержание работы специалиста определяется единством правовой нормы, технологической последовательности помощи и личностной готовности действовать в интересах ребёнка. Эти положения создают основание для дальнейшего рассмотрения практических форм и методов социальной работы в эмпирической части исследования.

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА И РАЗРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

2.1 Современное состояние системы жизнеустройства детей-сирот в регионе и организация деятельности службы по устройству детей в семью

Когда переходишь от теории к практике, сразу становится заметно: общая линия государства уже давно не про «содержать ребёнка в учреждении», а про то, чтобы он как можно быстрее оказался в семье. В научной литературе этот курс называют деинституционализацией. Е. И. Холостова формулирует его прямо: «приоритетом социальной политики выступает сохранение ребёнка в кровной семье и, при невозможности этого, устройство в замещающую семью»[59]. Ту же логику закрепляет Конвенция о правах ребёнка: «государства-участники обеспечивают, чтобы ребёнок не

разлучался со своими родителями вопреки их желанию, за исключением случаев, когда компетентные органы определяют… что такое разлучение необходимо в наилучших интересах ребёнка»[2]. Конституция Российской Федерации дополняет это базовым положением: «материнство и детство, семья находятся под защитой государства»[4]. В Декларации прав ребёнка тоже звучит ясная норма: «ребёнок для полного и гармоничного развития его личности нуждается в любви и понимании»[1].

На федеральном уровне картина последних лет выглядит довольно однозначно. По данным Минпросвещения России за 2025 год общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилась на 6,8 % и составила 317 052 человека. Число вновь выявленных детей снизилось на 12,4 % — до 34 678 человек, а численность социальных сирот уменьшилась на 16,9 %. Одновременно выросло число родителей, восстановленных в родительских правах: прирост составил 33,1 % (1 181 человек). Эти цифры важно держать вместе, потому что они показывают не только «убыль» сиротства, но и усиление работы с кровной семьёй до и после кризисной ситуации. Как отмечает М. О. Егорова, «профилактика сиротства становится актуальной задачей социальных служб именно тогда, когда помощь семье оказывается до лишения родительских прав»[38]. Н. З. Малярова уточняет: «социальная защита детства должна строиться как система предупреждения, а не только как реакция на уже свершившееся сиротство»[43]. В обзорах журнала «Семья» подчёркивается: «снижение социального сиротства устойчиво лишь при сочетании правовых мер и живого сопровождения семьи»[86].

Семейный кодекс Российской Федерации выстраивает жёсткую иерархию форм устройства. В нём прямо сказано: «каждый ребёнок имеет право жить и воспитываться в семье»[5]. И дальше кодекс закрепляет: «ребёнок имеет право на защиту своих прав и законных интересов»[5]. На практике это означает, что родственная опека идёт первой: ребёнка стараются передать бабушкам, дедушкам, тётям, дядям — тем, кого в

профессиональной среде всё чаще называют «близкими взрослыми». Далее следует усыновление, при котором ребёнок приобретает права биологического члена семьи, включая наследственные. Самой массовой формой остаётся опека и попечительство, а приёмная и патронатная семьи выступают уже как профессиональные модели замещающего родительства с вознаграждением. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» подчёркивает: «опека и попечительство устанавливаются для защиты прав и интересов граждан… нуждающихся в опеке или попечительстве»[11]. Там же зафиксировано: «опекуны и попечители обязаны заботиться о содержании своих подопечных, об обеспечении их уходом и лечением, о их воспитании»[11]. Интернатам отводится роль временной меры — для экстренного изъятия из опасной среды или при тяжёлых медицинских показаниях. Л. М. Шипицына замечает: «длительное пребывание в учреждении усиливает депривационные последствия и затрудняет последующую семейную адаптацию»[58].

После принятия постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 детские дома перестали восприниматься как «место постоянного проживания». Их переориентировали в центры содействия семейному устройству. С января 2025 года для каждого воспитанника обязателен индивидуальный план развития и жизнеустройства. В логике Федерального закона о дополнительных гарантиях цель такого плана близка к формуле: «создание условий для полноценного физического, интеллектуального, духовного и нравственного развития»[10]. В план обычно входят психолого-медико-педагогическая реабилитация, работа с кровными родственниками, подготовка к семейному устройству и обучение навыкам самостоятельной жизни. Н. П. Иванова и И. А. Бобылева справедливо замечают: «адаптация ребёнка в замещающей семье начинается ещё до передачи — с диагностики ресурсов ребёнка и подготовки взрослых»[39]. В. Н. Ослон добавляет: «замещающая семья нуждается в сопровождении на всём протяжении адаптации, особенно если ребёнок имеет

травматический опыт»[71]. И. А. Бобылева отдельно фиксирует: «вторичное сиротство чаще всего растёт там, где после устройства семьи остаются без профессиональной поддержки»[72].

Отдельный тренд 2024–2025 годов — усиление работы с биологическими семьями до момента лишения прав. Специализированные службы кризисного сопровождения помогают юридически, психологически, через медиацию. В ряде субъектов за счёт такой поддержки в кровных семьях удаётся сохранить до 87 % детей группы риска. В Пермском крае, например, доля детей-сирот, воспитывающихся в семьях, достигает 95 %. Эти ориентиры полезны и для Орловской области: они показывают, к какому результату стремится вся страна. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка» напоминает: «государственная политика в интересах детей является приоритетной»[8]. Закон о профилактике безнадзорности требует: «проведение индивидуальной профилактической работы» с несовершеннолетними и семьями[9]. Е. И. Холостова сводит это к рабочей формуле: «социальная работа с детьми-сиротами эффективна лишь при согласованности органов опеки, учреждений и служб сопровождения»[59].

Для выпускников сохраняют силу гарантии Федерального закона от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ. Закон прямо предусматривает: «дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»[10]. В жилищной части звучит жёстко: «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей… имеют право на обеспечение жилыми помещениями»[10]. На практике именно жилищный вопрос чаще всего «вытягивает» обращения к уполномоченным по правам ребёнка. Т. С. Гусева в комментарии к закону отмечает: «жилищные права детей-сирот носят специальный характер и требуют активного содействия уполномоченных органов»[34].

Именно это видно на материалах Орловской области, где «жилищные права детей-сирот носят специальный характер и требуют активного

содействия уполномоченных органов»[34]. В отчёте уполномоченного по правам ребёнка Константина Домогатского, представленном в Орловском областном Совете народных депутатов, подчёркивалось: «особое место в работе детского правозащитного института занимают вопросы, связанные с положением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, условиями их проживания и соблюдением их жилищных прав»[86]. За год к нему поступило 98 обращений имущественного характера — о признании нуждающимися, об отказах в предоставлении жилья. На 1 января 2025 года в сводном списке на обеспечение жилыми помещениями находилось 981 человек (годом ранее — 1 056). Численность лиц, достигших совершеннолетия, чьё право на жильё ещё не реализовано, составила 589 человек (на 1 января 2024 года — 649); из них 296 находились на полном государственном обеспечении в образовательных организациях и организациях социального обслуживания, проживали в общежитиях, проходили военную службу по призыву, отбывали наказание либо подали заявления об отсрочке. В докладе отдельно сказано: «численность лиц, достигших совершеннолетия, чьё право на предоставление жилого помещения не реализовано… составило 589 человек»[86].

В минувшем году детям-сиротам предоставили 175 жилых помещений из муниципального специализированного фонда, из них 72 квартиры — по решениям судов (в 2023 году — 84). По жилищным сертификатам приобрели 43 помещения (в 2023 году — 40). Вместе с тем на 1 января 2025 года по 66 детям-сиротам судебные решения об обеспечении жильём ещё не были исполнены (годом ранее — 79). По данным департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области на исполнение полномочий в 2024 году предусмотрели 559,118 млн рублей. Муниципалитеты приобрели 176 жилых помещений на 456,044 млн рублей, а 40 сертификатов реализовали на сумму 100,311 млн рублей. Эти показатели мы сохраняем как базовые для дальнейшего анализа: они же будут сопоставляться с данными 2025 года о

201 квартире и 14 сертификатах. Журнал «Семья» в региональных обзорах отмечает: «жилищная обеспеченность выпускников остаётся критическим индикатором качества постинтернатного сопровождения»[86].

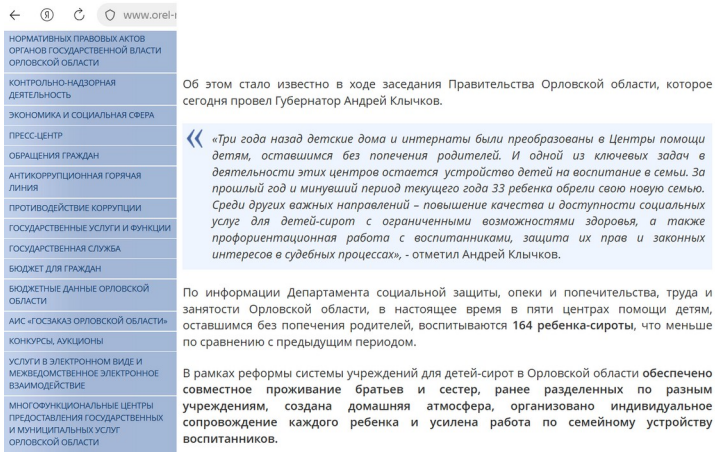


Рисунок 3 – Данные с сайта Правительства Орловской области

Если смотреть на официальные материалы Правительства Орловской области, этап реформирования учреждений в целом завершён: детские дома преобразованы в центры помощи, а «длительное пребывание в учреждении усиливает депривационные последствия и затрудняет последующую семейную адаптацию»[58]. На момент отчётного периода в пяти таких центрах воспитывались 164 ребёнка — заметно меньше, чем раньше. За прошедший год и истекший период текущего года семейное устройство получили 33 ребёнка. Братья и сёстры, которых прежде разлучали, живут вместе в небольших группах по 6–8 человек. Как отмечает Л. М. Шипицына, «сохранение родственных связей снижает травму разлуки и облегчает последующую адаптацию»[58]. И. В. Дубровина подчёркивает: «особенности психического развития детей вне семьи требуют специальной коррекционной работы»[36]. Отдельно усиливается поиск семей для воспитанников: 26 ребят из Донецкой Народной Республики уже обрели дом — 7 вернулись к родным, 19 переданы под опеку. А. Ш. Шахманова пишет: «воспитание детей-сирот должно воссоздавать атмосферу заботы и устойчивости, близкую к семейной»[57].

В планах на 2026 год — открытие в центре «Остров детства» реабилитационного отделения для детей с ограниченными возможностями здоровья. В формате двухнедельных бесплатных курсов учреждение сможет принимать до 10 детей вместе с сопровождающими взрослыми, с проживанием и питанием. Это важный штрих: регион двигается не только к «количеству» семейных устройств, но и к доступности услуг для детей с особыми потребностями. В. Н. Ослон в этом контексте права: «для ребёнка с ограниченными возможностями здоровья семейное устройство без специальной поддержки взрослых часто оказывается неустойчивым»[71].

Финансирование жилищного направления в Орловской области растёт ежегодно: на обеспечение жильём предусмотрено 600,8 млн рублей (+2,5 %), из них 50,8 млн — на сертификаты; объявлены торги на 22 квартиры в областном центре и 19 — в Орловском муниципальном округе. За семь лет направлено свыше 3 млрд рублей, что позволило улучшить условия 1 755 человек. Как подчёркивают региональные обзоры, «жилищная обеспеченность выпускников остаётся критическим индикатором качества постинтернатного сопровождения»[86]. Губернатор А. Клычков фиксирует преимущественное право участников СВО: с 2023 года — 17 квартир и 11 сертификатов.

Сертификаты в Орловской области действуют с 2021 года и позволяют самостоятельно подбирать жильё на вторичном рынке. За пять лет реализовано 107 сертификатов, из них 14 — в 2025 году. По отчётным материалам 2025 года исполнение полномочий выглядело так: 201 квартира по договорам специализированного найма на сумму 534,5 млн рублей и 14 сертификатов на 36,3 млн рублей. Размер выплаты по сертификату рассчитывается исходя из нормы 33 квадратных метра общей площади, умноженной на среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра в Орловской области; по состоянию на 31 декабря 2025 года размер выплаты составил 2 529,7 тыс. рублей. Эти цифры согласуются с данными уполномоченного и департаментов и далее используются в разделе 2.2 без

«пересчёта» под другой регион. Распоряжение Правительства Российской Федерации о комплексе мер по предоставлению жилья детям-сиротам задаёт общий федеральный контур этой работы[14].

Организация деятельности службы по устройству детей в семью в Орловской области опирается на ту же нормативную рамку, что и в целом по стране, но наполняется региональной практикой. Федеральный закон требует «формирование и использование государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей»[12]. Приказ о порядке формирования банка данных задаёт процедурную дисциплину специалистам[21]. Постановление о полномочиях по содействию устройству детей в семьи закрепляет организационную сторону процесса[16]. В терминах Е. И. Холостовой это означает: «социальная работа должна соединять правовую защиту, психологическую помощь и организацию жизненной среды ребёнка»[59]. Н. П. Иванова резюмирует практический смысл подбора: «риск вторичного отказа снижается, если при подборе семьи учитываются темперамент ребёнка, его травматический опыт и реальные ресурсы взрослых»[39].

На уровне региона служба работает в трёх контурах. Первый — профилактика: «не допустить изъятия, помочь кровной семье»[59]. Второй — устройство через банк данных и видеопаспорта. Третий — сопровождение замещающей семьи, чтобы снизить риск возврата. В Орловской области эти контуры видны предметно: около 220 потенциальных опекунов в региональной базе, более 300 видеопаспортов, 10 школ приёмных родителей, программа переподготовки действующих опекунов. Как отмечает журнал «Семья», «региональная практика сильна тогда, когда общие принципы деинституционализации наполняются местными ресурсами и понятными индикаторами»[86]. И. А. Бобылева подтверждает: «переподготовка действующих опекунов — это не формальность, а способ снизить вторичное сиротство»[72].

Если кратко суммировать состояние системы в регионе на момент исследования, получается следующая устойчивая картина. В учреждениях интернатного типа (центрах помощи) воспитываются 164 ребёнка в пяти организациях; за отчётный период семейное устройство получили 33 ребёнка; за два года в кровные семьи возвращены 45 детей; в сводном жилищном списке на 1 января 2025 года — 981 человек; в 2025 году обеспечены жильём 201 квартира и 14 сертификатов. Общероссийский фон при этом — 317 052 ребёнка-сироты и ребёнка, оставшихся без попечения родителей, при снижении выявления и росте восстановления родительских прав. Именно эти величины будут опорными при разработке дорожной карты и индивидуального плана в параграфе 2.2.

Не менее важно удерживать сквозную согласованность правовых и научных формулировок. Опорные тезисы уже звучали выше и здесь сводятся к единому контуру: «наилучшие интересы ребёнка являются первоочередным соображением»[2]; «каждый ребёнок имеет право жить и воспитываться в семье»[5]; «государственная политика в интересах детей является приоритетной»[8]; «дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»[10]; «приоритетом социальной политики выступает сохранение ребёнка в кровной семье и, при невозможности этого, устройство в замещающую семью»[59]; «социальная работа с детьми-сиротами эффективна лишь при согласованности органов опеки, учреждений и служб сопровождения»[59]; «замещающая семья нуждается в сопровождении на всём протяжении адаптации»[71]; «переподготовка действующих опекунов — это не формальность, а способ снизить вторичное сиротство»[72]; «жилищная обеспеченность выпускников остаётся критическим индикатором качества постинтернатного сопровождения»[86].

Отдельного комментария заслуживает и «человеческая» сторона статистики. За цифрами 317 052 и 34 678 стоят конкретные детские истории, а за показателями Орловской области — 164 воспитанника пяти центров и

очередь из 981 человека на жильё. Поэтому специалисту недостаточно «знать закон»: нужно уметь читать норму как рабочую инструкцию. Семейный кодекс требует учитывать, что «ребёнок имеет право на защиту своих прав и законных интересов»[5]. Федеральный закон об опеке уточняет обязанность взрослых: «опекуны и попечители обязаны заботиться о содержании своих подопечных, об обеспечении их уходом и лечением, о их воспитании»[11]. Закон о гарантиях сирот добавляет социальный контур: «создание условий для полноценного физического, интеллектуального, духовного и нравственного развития»[10]. Е. И. Холостова сводит эти нормы к профессиональной установке: «социальная работа должна соединять правовую защиту, психологическую помощь и организацию жизненной среды ребёнка»[59]. Н. П. Иванова настаивает: «риск вторичного отказа снижается, если при подборе семьи учитываются темперамент ребёнка, его травматический опыт и реальные ресурсы взрослых»[39]. В. Н. Ослон предупреждает практикующих: «вторичный отказ часто связан не с „плохим ребёнком“, а с неподготовленностью взрослых и отсутствием поддержки»[71]. И. А. Бобылева формулирует управленческий вывод: «вторичное сиротство чаще всего растёт там, где после устройства семьи остаются без профессиональной поддержки»[72]. Журнал «Семья» фиксирует региональный критерий зрелости системы: «региональная практика сильна тогда, когда общие принципы деинституционализации наполняются местными ресурсами и понятными индикаторами»[86]. Именно поэтому в Орловской области так важны не только 201 квартира и 14 сертификатов 2025 года, но и 10 школ приёмных родителей, программа переподготовки опекунов, 45 возвратов в кровные семьи и более 300 видеопаспортов.

Таким образом, современное состояние системы жизнеустройства в Орловской области отражает общероссийский курс на семейное устройство, но сохраняет острые практические узлы: очередь на жильё, исполнение судебных решений, подготовка и сопровождение замещающих семей, работа

с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Специалист по социальной работе оказывается в центре этих узлов: именно он связывает норматив, диагностику ребёнка и реальные возможности семьи. П. Я. Циткилов точно замечает: «технология социальной работы требует не только нормативной грамотности, но и устойчивых навыков межведомственной координации»[56].

2.2 Разработка дорожной карты и индивидуального плана развития детей-сирот

Практический опыт служб по устройству детей в семью заметно сдвинулся от административного распределения к семейно-ориентированной модели. Если раньше главное было быстро оформить статус, то сейчас ставка делается на «межведомственное взаимодействие, профилактику социального сиротства и профессиональное сопровождение»[59]. Е. И. Холостова формулирует это жёстко: «технология социальной работы с ребёнком, оставшимся без попечения родителей, начинается с оценки ситуации семьи и заканчивается устойчивым жизнеустройством»[59]. Она же уточняет: «профессионализм специалиста проявляется в способности удерживать случай целиком, а не отдельными „точечными“ услугами»[59]. В Орловской области эта логика читается и в жилищной политике, и в программах подготовки приёмных родителей, и в работе центров помощи детям.

На федеральном уровне ориентиром служит программа «Дети в семье», стартовавшая в 2022 году. Она внедряет «семьесберегающие технологии»[86] и опирается на сеть из 257 ресурсно-методических служб (начало 2025 года). Их задача — сопровождать кровные семьи в кризисе, не допуская изъятия, и поддерживать замещающие семьи. В пилотных регионах за счёт региональных консилиумов по оценке обоснованности помещения в учреждения число детей на круглосуточном стационарном пребывании сократилось на 14,7 % за год — с 21 152 до 18 051 человека. Дома ребёнка постепенно перепрофилируются в центры содействия семейному устройству: основной услугой становится не «содержание», а подготовка к жизни в семье

и работа с биологическими родителями. Как пишет Н. З. Малярова, «социальная защита детства должна строиться как система предупреждения, а не только как реакция на уже свершившееся сиротство»[43]. М. О. Егорова вторит: «профилактика сиротства — актуальная задача социальных служб»[38]. Журнал «Семья» фиксирует: «семьесберегающие технологии оправдывают себя там, где кризисная помощь приходит раньше изъятия»[86].

Московская модель «Каждому ребёнку — своя семья» часто приводится как эталон: доля семейного устройства здесь около 95 %. В столице работают институт медиации (досудебное урегулирование споров между кровными родственниками и кандидатами в опекуны), 18 школ приёмных родителей и технология сопоставления компетенций — когда смотрят не только на жильё и доход, но и на психологическую совместимость. Н. П. Иванова отмечает: «риск вторичного отказа снижается, если при подборе семьи учитываются темперамент ребёнка, его травматический опыт и реальные ресурсы взрослых»[39]. Вместе с И. А. Бобылевой она подчёркивает: «адаптация ребёнка в замещающей семье начинается ещё до передачи — с диагностики ресурсов ребёнка и подготовки взрослых»[39]. Для Орловской области московский опыт важен не как копирование «один в один», а как набор рабочих решений, которые уже частично внедрены: видеопаспорта, школы приёмных родителей, межведомственные советы. Конвенция о правах ребёнка в этом смысле задаёт общий нравственно-правовой горизонт: «наилучшие интересы ребёнка являются первоочередным соображением»[2].



Рисунок 4 – Статистика обеспечения жильём детей-сирот

Жилищный блок дорожной карты в регионе нельзя отделять от семейного устройства. По данным исполнения полномочий в 2025 году в Орловской области предоставлено 201 жилое помещение по договорам специализированного найма на сумму 534,5 млн рублей и реализовано 14 жилищных сертификатов на 36,3 млн рублей. Размер выплаты по сертификату рассчитывается исходя из 33 квадратных метров общей площади, умноженных на среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра в Орловской области; на 31 декабря 2025 года размер выплаты составил 2 529,7 тыс. рублей. Эти показатели согласуются с ранее приведёнными данными раздела 2.1: на 1 января 2025 года в сводном списке находилось 981 человек, нереализованное право у достигших совершеннолетия имели 589 человек, а за пять лет действия сертификатов реализовано 107 документов, в том числе 14 — в 2025 году. Федеральный закон № 159-ФЗ прямо закрепляет: «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей… имеют право на обеспечение жилыми помещениями»[10]. Там же сказано о необходимости «дополнительных гарантий по социальной поддержке»[10]. Т. С. Гусева поясняет: «жилищные права детей-сирот носят специальный характер и требуют активного содействия уполномоченных органов»[34]. Для специалиста по социальной работе это означает, что индивидуальный план старшеклассника и выпускника обязан включать жилищный трек — иначе «семейное

устройство» и «самостоятельная жизнь» остаются словами на бумаге. Журнал «Семья» добавляет: «жилищная обеспеченность выпускников остаётся критическим индикатором качества постинтернатного сопровождения»[86].

Цифровые инструменты тоже входят в дорожную карту. Использование государственного банка данных о детях делает подбор анкет прозрачнее. Закон прямо ориентирует на «формирование и использование государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей»[12]. Индивидуальные планы развития и жизнеустройства, введённые приказом Минпросвещения, составляются в течение месяца после помещения ребёнка в организацию и пересматриваются не реже чем раз в полгода. В методической логике подчёркивается необходимость «фиксировать шаги по поиску семьи и обеспечивать непрерывность сопровождения»[21]. Кадровый контур при этом остаётся уязвимым: дефицит специалистов актуален для многих субъектов. Отсюда идея федеральных и региональных методических площадок для психологов, социальных педагогов и юристов. П. Я. Циткилов справедливо пишет: «технология социальной работы требует не только нормативной грамотности, но и устойчивых навыков межведомственной координации»[56]. А. С. Дудкин уточняет: «технологии социальной работы с семьёй и детьми требуют связки диагностики, планирования и контроля»[37]. Л. В. Мардахаев добавляет: «социально-педагогическое сопровождение эффективно, когда оно носит непрерывный и командный характер»[44].

Отдельный успешный сюжет — профилактика отказов от новорождённых. Региональный опыт специализированных центров показывает: при работе медиаторов, юристов и адресной материальной помощи в биологических семьях удаётся сохранить до 87 % младенцев группы риска. Это перекликается с позицией уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка: поиск семьи должен начинаться с ближайшего окружения ребёнка. Для Орловской области тот же

принцип выражен иначе, но по сути одинаково: ключевым приоритетом остаётся «сохранение ребёнка в кровной семье»[59]. Семейный кодекс поддерживает эту линию нормой: «каждый ребёнок имеет право жить и воспитываться в семье»[5]. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» напоминает: «опека и попечительство устанавливаются для защиты прав и интересов»[11].

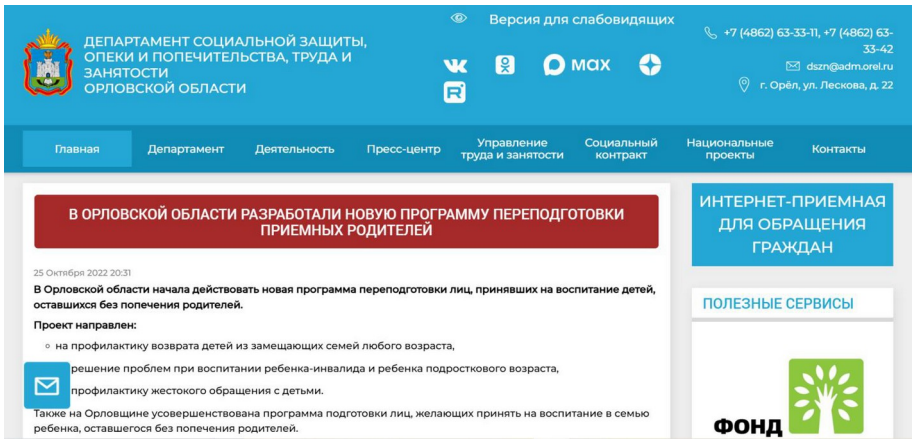


Рисунок 5 – Данные с сайта Департамента социальной защиты

Именно в Орловской области внедрена обновлённая система поддержки замещающих семей. На сайте Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области опубликована информация о новой программе переподготовки приёмных родителей. Цели программы сформулированы практично: «профилактика возврата детей из замещающих семей любого возраста»; «решение проблем при воспитании ребёнка-инвалида и ребёнка подросткового возраста»; «профилактика жестокого обращения с детьми». Параллельно модернизирована и программа подготовки тех, кто только планирует принять ребёнка. В. Н. Ослон подчёркивает: «замещающая семья нуждается в сопровождении на всём протяжении адаптации, особенно если ребёнок имеет травматический опыт или ограниченные возможности здоровья»[71]. И далее: «вторичный отказ часто связан не с „плохим ребёнком“, а с неподготовленностью взрослых и отсутствием поддержки»[71]. И. А. Бобылева добавляет: «переподготовка действующих опекунов — это не формальность, а способ снизить вторичное

сиротство»[72]. В её логике «вторичное сиротство чаще всего растёт там, где после устройства семьи остаются без профессиональной поддержки»[72].

Обучение и сопровождение ведут 10 центров психолого-медико-социального сопровождения («Школы приёмных родителей»), которые также помогают семьям в кризисе. Для поиска родителей размещено более 300 видеопаспортов; в базе около 220 кандидатов. За два года в родные семьи возвращены 45 детей — рядом с 164 воспитанниками в пяти центрах и 33 семейными устройствами. Как отмечает журнал «Семья», «эффективность сопровождения измеряется не числом мероприятий, а устойчивостью семейного устройства и качеством жизни ребёнка»[86].

Будущих опекунов учат работать с травматическим опытом и трудным поведением (лекции, тренинги, разбор случаев, аттестация); действующие опекуны проходят переподготовку. Сопровождение включает мониторинг и психолого-правовую поддержку; координацию ведёт Совет по вопросам развития семейного устройства в Орле. Л. Я. Олиференко пишет о необходимости «инноваций в работе специалистов социально-педагогических учреждений»[48]. Ф. А. Мустаева подчёркивает: «социальный педагог обязан видеть не только дефициты ребёнка, но и его ресурсы»[47]. И. В. Дубровина напоминает: «особенности психического развития детей вне семьи требуют специальной коррекционной работы»[36].

Правовая рамка выбора формы устройства остаётся общей для всех регионов. Конвенция о правах ребёнка закрепляет право жить в семейной среде и принцип наилучших интересов[2]. Конституция Российской Федерации защищает семью нормой: «материнство и детство, семья находятся под защитой государства»[4]. Семейный кодекс выстраивает иерархию: усыновление, опека (попечительство), приёмная семья и прямо говорит: «ребёнок имеет право на защиту своих прав и законных интересов»[5]. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» детализирует статусы опекуна и попечителя: «опекуны и попечители обязаны заботиться о содержании своих подопечных»[11]. Регионы могут развивать

дополнительные модели — патронат, детские деревни, приходские формы, — но базовая логика одна. Комментаторы к законодательству о гарантиях сирот напоминают: «усыновление юридически приравнивает ребёнка к кровным детям»[34]. Опека сохраняет фамилию и связь с кровными родственниками; родственная опека остаётся абсолютным приоритетом, потому что, по словам Л. М. Шипицыной, «сохранение родственных связей снижает травму разлуки и облегчает последующую адаптацию»[58]. Приёмная семья по договору особенно востребована для братьев и сестёр и для детей со сложными диагнозами: кодекс запрещает разлучать детей, если они знают друг друга и проживали вместе[5].

Деинституционализация в этом контексте — не лозунг и не просто закрытие детских домов, а системная реформа: «предотвратить попадание в учреждение, сократить срок пребывания, вернуть в семью либо подобрать замещающую»[59]. Е. И. Холостова формулирует приоритет коротко: «приоритетом социальной политики выступает сохранение ребёнка в кровной семье и, при невозможности этого, устройство в замещающую семью»[59]. Принципы здесь известные, но их стоит проговорить «по-человечески». Сначала — кровная семья и кризисная помощь. Потом — профилактика социального сиротства, чтобы не доводить дело до лишения прав. Дальше — жёсткое ограничение времени в интернате: ребёнок не должен «застревать» годами. И наконец — постинтернатное сопровождение для тех подростков, кого не успели устроить до совершеннолетия. В ряде регионов доля детей в семьях уже около 95 %, а в учреждениях остаётся порядка 5 %. Орловская область движется в ту же сторону: 164 ребёнка в центрах на весь регион — это уже не «массовый интернат», а относительно компактный контингент, с которым можно работать индивидуально. А. Ш. Шахманова пишет: «воспитание детей-сирот должно воссоздавать атмосферу заботы и устойчивости, близкую к семейной»[57].

Именно поэтому дорожная карта специалиста в Орловской области выстраивается как «последовательность связанных шагов»[56], а не как набор разрозненных мероприятий.

Первый блок дорожной карты — ранняя профилактика: специалист совместно с органами опеки выявляет семьи группы риска и организует сопровождение. Здесь уместны «индивидуальная профилактическая работа»[9] и тезис М. О. Егоровой: «профилактика сиротства становится актуальной задачей социальных служб именно тогда, когда помощь семье оказывается до лишения родительских прав»[38]. Цель блока — «снизить число изъятий» и увеличить долю случаев сохранения ребёнка в кровной семье[59].

Второй блок — диагностика и ведение случая: в течение месяца составляется индивидуальный план. Ф. А. Мустаева подчёркивает: «социальный педагог обязан видеть не только дефициты ребёнка, но и его ресурсы»[47]. Н. М. Платонова указывает на «целостный подход к теории и методике социальной работы»[52]. В орловских центрах группы по 6–8 человек и сиблинги живут вместе, поэтому план семьи сиблингов должен быть согласованным.

Третий блок — работа на возврат в кровную семью: реабилитация родителей и юридическое сопровождение. Региональный результат — 45 детей за два года. Конвенция требует учитывать: «разлучение необходимо… в наилучших интересах ребёнка»[2], а воссоединение также должно опираться на «наилучшие интересы ребёнка»[2].

Четвёртый блок — подбор замещающей семьи. Используются банк данных, видеопаспорта (более 300 роликов), база кандидатов (около 220 человек), школы приёмных родителей (10 центров). Здесь применяется сопоставление потребностей ребёнка и возможностей семьи. Н. П. Иванова и И. А. Бобылева пишут: «адаптация начинается с взаимной подготовки ребёнка и взрослых»[39]. Для детей с ограниченными возможностями здоровья и подростков подключается программа переподготовки опекунов,

описанная Департаментом социальной защиты Орловской области. В. Н. Ослон предупреждает: «замещающая семья нуждается в сопровождении на всём протяжении адаптации»[71].

Пятый блок — устройство и сопровождение с куратором и кризисной поддержкой центров. Журнал «Семья» формулирует критерий: «устойчивость семейного устройства и качество жизни ребёнка»[86]. Е. И. Холостова добавляет: «социальная работа с детьми-сиротами эффективна лишь при согласованности органов опеки, учреждений и служб сопровождения»[59].

Шестой блок — подготовка к самостоятельной жизни и жилищное обеспечение: профориентация, бытовые навыки, сопровождение очереди. Опорные цифры: 981 в списке на 1 января 2025 года; 201 квартира и 14 сертификатов в 2025 году; 600,8 млн рублей финансирования; преимущественное право участников СВО (17 квартир и 11 сертификатов с 2023 года). Закон № 159-ФЗ требует обеспечивать «дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»[10], а распоряжение о комплексе мер по жилью задаёт федеральный контур[14].

Седьмой блок — оценка и корректировка не реже чем раз в шесть месяцев. П. Я. Циткилов пишет: «технология социальной работы требует не только нормативной грамотности, но и устойчивых навыков межведомственной координации»[56]. А. С. Дудкин настаивает на «связке диагностики, планирования и контроля»[37].

Навыки ведения случая включают диагностику, межведомственное взаимодействие, коммуникацию, проектное мышление, кризисную интервенцию и документирование. Л. В. Мардахаев замечает: «социально-педагогическое сопровождение эффективно, когда оно носит непрерывный и командный характер»[44]. Е. С. Фоминых предупреждает: «социальная депривация» может закреплять позицию жертвы[55], поэтому план обязан работать на восстановление субъектности ребёнка.

Индивидуальный план развития и жизнеустройства — «главный рабочий документ» сопровождения[59]. Согласно требованиям Минпросвещения, первичный план разрабатывается в течение месяца. Структура включает три части.

Базовая часть описывает статус, здоровье, образование, заключения ПМПК и интересы; планово-результативная — мероприятия, сроки, ответственных и измеримые изменения; рекомендательная — предложения после выпуска или передачи в семью. План утверждается органом опеки с назначением куратора. Федеральный закон требует считать «государственную политику в интересах детей» приоритетной[8], поэтому план не может быть формальной бумагой.

Для Орловской области типовой план конкретизируется под региональные реалии: один из пяти центров; сиблинги в группе; жилищный список; маршрут в «Остров детства» при ОВЗ; связь с 10 школами и переподготовкой опекунов; критерии — устройство, возврат, жилищная очередь. И. В. Дубровина напоминает: «особенности психического развития детей вне семьи требуют специальной коррекционной работы»[36], а значит, «психологический» блок плана не может быть формальной строкой. Н. П. Иванова ещё раз фиксирует: «адаптация начинается с взаимной подготовки ребёнка и взрослых»[39].

Реализация плана требует конкретных задач, фиксации прогресса и корректировки при срывах; при переходе в семью — предварительных встреч. Ключевые компетенции — юридическая грамотность, аналитика и устойчивость. Л. Я. Олиференко пишет о необходимости «инноваций в работе специалистов социально-педагогических учреждений»[48]; Е. И. Холостова резюмирует: «социальная работа должна соединять правовую защиту, психологическую помощь и организацию жизненной среды ребёнка»[59].

Сводя дорожную карту к практическому алгоритму для Орловской области, получаем следующее. На входе — ребёнок в одном из пяти центров

(текущий контингент — 164 человека) либо семья в кризисе. На первом месяце — диагностика и индивидуальный план. Параллельно — работа с кровными родственниками (ориентир региона — 45 возвратов за два года) и поиск замещающей семьи через 300 с лишним видеопаспортов и базу из примерно 220 кандидатов. Подготовка взрослых — через 10 школ и программу переподготовки. После устройства — сопровождение против возвратов. Для выпускников — жилищный маршрут с опорой на цифры 2025 года (201 квартира, 14 сертификатов, 534,5 и 36,3 млн рублей) и плановый объём финансирования 600,8 млн рублей. Оценка — каждые шесть месяцев, с выходом на устойчивое семейное устройство либо на сопровождаемую самостоятельную жизнь.

Теория прямо объясняет орловскую практику: «технология социальной работы требует не только нормативной грамотности, но и устойчивых навыков межведомственной координации»[56]; «социально-педагогическое сопровождение эффективно, когда оно носит непрерывный и командный характер»[44]; «особенности психического развития детей вне семьи требуют специальной коррекционной работы»[36]. Отсюда значимость возврата 45 детей в кровные семьи, совместного проживания сиблингов и переподготовки опекунов.

Методический каркас дорожной карты опирается на уже приведённые нормы: «каждый ребёнок имеет право жить и воспитываться в семье»[5]; «наилучшие интересы ребёнка являются первоочередным соображением»[2]; «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей… имеют право на обеспечение жилыми помещениями»[10]; «технология социальной работы с ребёнком, оставшимся без попечения родителей, начинается с оценки ситуации семьи и заканчивается устойчивым жизнеустройством»[59]; «адаптация ребёнка в замещающей семье начинается ещё до передачи — с диагностики ресурсов ребёнка и подготовки взрослых»[39]; «замещающая семья нуждается в сопровождении на всём протяжении адаптации»[71]; «переподготовка действующих опекунов — это не формальность, а способ

снизить вторичное сиротство»[72]; «эффективность сопровождения измеряется не числом мероприятий, а устойчивостью семейного устройства и качеством жизни ребёнка»[86].

С практической точки зрения дорожная карта и план сходятся в требовании измеримости: нужно фиксировать, что изменилось для конкретного ребёнка из 164 воспитанников. Целевая рамка — «каждый ребёнок имеет право жить и воспитываться в семье»[5]; разлучение должно быть «необходимым в наилучших интересах ребёнка»[2]. Закон № 159-ФЗ требует «дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»[10]. Профессионально: «профессионализм специалиста проявляется в способности удерживать случай целиком»[59]; «замещающая семья нуждается в сопровождении на всём протяжении адаптации»[71]; «эффективность сопровождения измеряется не числом мероприятий, а устойчивостью семейного устройства и качеством жизни ребёнка»[86].

Такой алгоритм не противоречит федеральной модели «Дети в семье» и не подменяет её конструкциями иных субъектов: вся практическая часть исследования удерживает именно Орловскую область. Как подчёркивается в материалах журнала «Семья», «региональная практика сильна тогда, когда общие принципы деинституционализации наполняются местными ресурсами и понятными индикаторами»[86]. И. А. Бобылева и В. Н. Ослон подчёркивают: «устойчивость семейного устройства достигается при сочетании подготовки замещающих родителей, регулярного сопровождения и своевременной переподготовки опекунов»[72],[71]. Таким образом, дорожная карта специалиста замыкается на измеримом результате для конкретного ребёнка и создаёт логический переход к выводам по главе.

Выводы по главе 2

Анализ практического опыта и логика разработки индивидуального плана показывают, что система жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Орловской области развивается в

русле общероссийской деинституционализации, но имеет собственный, вполне конкретный «рисунок» цифр и решений. Е. И. Холостова формулирует общий принцип ясно: «приоритетом социальной политики выступает сохранение ребёнка в кровной семье и, при невозможности этого, устройство в замещающую семью»[59]. Конвенция о правах ребёнка закрепляет ту же ось через формулу «наилучшие интересы ребёнка»[2], а Семейный кодекс — через норму: «каждый ребёнок имеет право жить и воспитываться в семье»[5].

На федеральном фоне сохраняется снижение масштаба сиротства: 317 052 ребёнка в 2025 году (минус 6,8 %), 34 678 вновь выявленных (минус 12,4 %), сокращение числа социальных сирот на 16,9 %, рост восстановления родительских прав на 33,1 % (1 181 человек). В пилотных практиках стационарное пребывание сократилось на 14,7 % (с 21 152 до 18 051), сеть служб «Дети в семье» достигла 257 единиц, а в отдельных регионах доля семейного устройства приближается к 95 %, при этом в кровных семьях удаётся сохранять до 87 % детей группы риска. Эти ориентиры задают планку, с которой сопоставляется региональная работа. Как отмечает М. О. Егорова, «профилактика сиротства становится актуальной задачей социальных служб именно тогда, когда помощь семье оказывается до лишения родительских прав»[38].

В Орловской области институциональный контингент уже относительно компактен: 164 ребёнка в пяти центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей. За отчётный период семейное устройство получили 33 ребёнка, за два года в кровные семьи возвращены 45 детей, в работе с кандидатами задействованы около 220 потенциальных опекунов и более 300 видеопаспортов, подготовку ведут 10 школ приёмных родителей. Жилищный контур остаётся одним из самых напряжённых: на 1 января 2025 года в сводном списке — 981 человек; у достигших совершеннолетия не реализовано право у 589 человек; в 2025 году обеспечены 201 квартира на 534,5 млн рублей и 14 сертификатов на 36,3 млн

рублей; на следующий период предусмотрено 600,8 млн рублей. За пять лет реализовано 107 сертификатов. Эти показатели согласованы между параграфами 2.1 и 2.2 и не смешиваются с данными других субъектов. Федеральный закон № 159-ФЗ прямо требует обеспечивать «дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот»[10], включая право «на обеспечение жилыми помещениями»[10].

Главный практический вывод состоит в том, что эффективность деятельности специалиста по социальной работе в регионе определяется не числом «проведённых мероприятий», а способностью вести случай по полной дорожной карте: профилактика — диагностика и индивидуальный план — возврат в кровную семью либо подбор замещающей — сопровождение против вторичных отказов — жилищная и постинтернатная поддержка — регулярный пересмотр плана. Н. П. Иванова и И. А. Бобылева подчёркивают: «адаптация ребёнка в замещающей семье начинается ещё до передачи — с диагностики ресурсов ребёнка и подготовки взрослых»[39]. В. Н. Ослон предупреждает: «замещающая семья нуждается в сопровождении на всём протяжении адаптации»[71]. И. А. Бобылева добавляет: «переподготовка действующих опекунов — это не формальность, а способ снизить вторичное сиротство»[72]. Журнал «Семья» резюмирует критерий результата: «эффективность сопровождения измеряется не числом мероприятий, а устойчивостью семейного устройства и качеством жизни ребёнка»[86].

Нормативной опорой здесь выступают Семейный кодекс, законы о гарантиях сирот и об опеке, требования к индивидуальному плану развития и жизнеустройства; теоретической — подходы Е. И. Холостовой, Н. П. Ивановой, И. А. Бобылевой, В. Н. Ослон и практики, обобщаемые в профессиональной периодике. П. Я. Циткилов точно фиксирует условие успеха: «технология социальной работы требует… устойчивых навыков межведомственной координации»[56].

В сжатом виде вывод по главе можно прочитать и через цепочку цитат. «Наилучшие интересы ребёнка являются первоочередным соображением»[2]. «Каждый ребёнок имеет право жить и воспитываться в семье»[5]. «Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»[10]. «Приоритетом социальной политики выступает сохранение ребёнка в кровной семье и, при невозможности этого, устройство в замещающую семью»[59]. «Адаптация ребёнка в замещающей семье начинается ещё до передачи»[39]. «Замещающая семья нуждается в сопровождении на всём протяжении адаптации»[71]. «Переподготовка действующих опекунов — это не формальность, а способ снизить вторичное сиротство»[72]. «Эффективность сопровождения измеряется не числом мероприятий, а устойчивостью семейного устройства и качеством жизни ребёнка»[86]. Эти формулы прямо стыкуются с орловскими показателями 164 / 33 / 45 / 981 / 201 / 14 и объясняют, зачем специалисту нужна полная дорожная карта, а не набор разовых услуг.

Иными словами, вывод по главе не сводится к перечню мер. Он сводится к связке нормы, цифры и действия специалиста. Конвенция требует исходить из «наилучших интересов ребёнка»[2]. Семейный кодекс утверждает: «каждый ребёнок имеет право жить и воспитываться в семье»[5]. Закон о гарантиях сирот говорит о «дополнительных гарантиях»[10] и праве «на обеспечение жилыми помещениями»[10]. Е. И. Холостова настаивает: «приоритетом социальной политики выступает сохранение ребёнка в кровной семье и, при невозможности этого, устройство в замещающую семью»[59]. Н. П. Иванова напоминает о подготовке сторон: «адаптация ребёнка в замещающей семье начинается ещё до передачи»[39]. В. Н. Ослон — о длительности поддержки: «замещающая семья нуждается в сопровождении на всём протяжении адаптации»[71]. И. А. Бобылева — о профилактике возвратов: «переподготовка действующих опекунов — это не формальность, а способ снизить вторичное сиротство»[72]. Журнал «Семья»

— о критерии результата: «устойчивостью семейного устройства и качеством жизни ребёнка»[86]. На этих основаниях и строится практическая часть работы по Орловской области.

Таким образом, глава 2 подтверждает: в Орловской области созданы базовые условия для семейно-ориентированной модели, но устойчивость результата зависит от качества индивидуального планирования, межведомственной связки и реального сопровождения замещающих семей. Разработанная дорожная карта и логика индивидуального плана как раз и направлены на то, чтобы перевести эти условия из отчётных показателей в повседневную работу специалиста.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполненная выпускная квалификационная работа подтвердила: деятельность специалиста по социальной работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, остаётся ключевым звеном политики деинституционализации. Конвенция о правах ребёнка требует: «наилучшие интересы ребёнка являются первоочередным соображением»[2]. Семейный кодекс утверждает: «каждый ребёнок имеет право жить и воспитываться в семье»[5]. Конституция закрепляет: «материнство и детство, семья находятся под защитой государства»[4]. Е. И. Холостова формулирует приоритет: «приоритетом социальной политики выступает сохранение ребёнка в кровной семье и, при невозможности этого, устройство в замещающую семью»[59]. На этих основаниях строится главный вывод: эффективность специалиста измеряется устойчивостью семейного устройства и целостностью ведения случая.

Теоретический анализ показал особый характер объекта. Сиротство включает и биологическую утрату родителей, и ситуации, когда забота фактически не осуществляется. В научной литературе оно определяется как «социальное явление, обусловленное наличием в обществе детей, родители которых умерли, а также детей, оставшихся без попечения родителей вследствие лишения родительских прав… и в иных случаях, установленных

законом»[45]. Социальное сиротство доминирует, поэтому сопровождение работает с травмой, депривацией и нарушением привязанности. И. В. Дубровина подчёркивает: «особенности психического развития детей вне семьи требуют специального психолого-педагогического сопровождения»[36]. Психологические исследования фиксируют: «неполнота эмоциональной жизни в сиротских учреждениях вызывает у ребёнка… психические расстройства и нарушения социальной адаптации»[63]. Л. М. Шипицына резюмирует: «наибольшие трудности… наблюдаются в эмоционально-волевой сфере, нарушении социального взаимодействия, неуверенности в себе»[58]. М. К. Бардышевская добавляет: «нарушения привязанности у детей, воспитывающихся вне семьи, проявляются в сочетании потребности в близости с неумением её реализовать конструктивно»[63]. Отсюда необходим переход от модели простого обеспечения жизнедеятельности к технологии ведения случая.

Нормативно-правовой контур задаёт обязательную логику действий. Федеральный закон № 159-ФЗ закрепляет «дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»[10] и право «на обеспечение жилыми помещениями»[10]. Закон об опеке и попечительстве ориентирует на то, что «опека и попечительство устанавливаются для защиты прав и интересов»[11]. Е. И. Холостова уточняет условие результата: «социальная работа с детьми-сиротами эффективна лишь при согласованности органов опеки, учреждений и служб сопровождения»[59]. Методические подходы к индивидуальному плану развития усиливают требование: план должен фиксировать измеримые шаги, мнение ребёнка и регулярный пересмотр, а не оставаться формальной бумагой.

Профессиональный портрет специалиста соединяет правовую грамотность, диагностические и организационные умения, эмпатию и эмоциональную устойчивость. Функции специалиста работают только в связке. П. Я. Циткилов отмечает: «технология социальной работы требует…

устойчивых навыков межведомственной координации»[56]. Ф. А. Мустаева добавляет: «социальный педагог обязан видеть не только дефициты ребёнка, но и его ресурсы»[47]. М. О. Егорова фиксирует смысл ранней помощи: «профилактика сиротства становится актуальной задачей социальных служб именно тогда, когда помощь семье оказывается до лишения родительских прав»[38]. И. А. Бобылева подчёркивает: «подготовка воспитанников к самостоятельной жизни должна начинаться задолго до выпуска и включать освоение бытовых, правовых и коммуникативных навыков»[72].

Практическая часть на материале Орловской области показала движение региона в русле общероссийской деинституционализации при относительно компактном институциональном контингенте: 164 ребёнка в пяти центрах помощи. За отчётный период семейное устройство получили 33 ребёнка, за два года в кровные семьи возвращены 45 детей; в работе задействованы около 220 потенциальных опекунов, более 300 видеопаспортов и 10 школ приёмных родителей. Жилищный контур остаётся напряжённым: на 1 января 2025 года в сводном списке — 981 человек; в 2025 году обеспечены 201 квартира и 14 сертификатов. Семейно-ориентированная модель в Орле и области уже повседневная практика, но устойчивость результата зависит от качества индивидуального планирования и реального сопровождения семей.

Анализ практики выявил главные барьеры: формализм индивидуальных планов, фрагментарность межведомственного взаимодействия, риск профессионального выгорания на кризисных контактах. Наиболее рабочими инструментами выглядят консилиумы, наставничество и системное сопровождение замещающих семей. Н. П. Иванова и И. А. Бобылева подчёркивают: «адаптация ребёнка в замещающей семье начинается ещё до передачи — с диагностики ресурсов ребёнка и подготовки взрослых»[39]. В. Н. Ослон предупреждает: «замещающая семья нуждается в сопровождении на всём протяжении адаптации»[71]. И. А. Бобылева добавляет: «переподготовка действующих опекунов — это не

формальность, а способ снизить вторичное сиротство»[72]. Г. В. Семья резюмирует критерий результата: «эффективность сопровождения измеряется не числом мероприятий, а устойчивостью семейного устройства и качеством жизни ребёнка»[86].

На этой основе предложена дорожная карта полной логики ведения случая: ранняя профилактика; диагностика и индивидуальный план; возврат в кровную семью либо подбор замещающей; сопровождение против вторичных отказов; жилищная и постинтернатная поддержка; регулярный пересмотр плана. Практическая значимость выводов состоит в том, что рекомендации можно использовать при корректировке шаблонов индивидуального плана, организации супервизии и уточнении межведомственных регламентов в учреждениях Орловской области.

Таким образом, цель работы достигнута: организация деятельности специалиста проанализирована, а предложенные меры направлены на повышение эффективности сопровождения в связке нормы, региональной практики Орловской области и повседневного ведения случая.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Декларация прав ребенка : принята резолюцией 1386 (XIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 г. // Права и свободы личности. Международные документы и комментарии. – Вып. 11. – М., 1995.
2. Конвенция о правах ребенка : принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г. // Сборник международных договоров СССР. – Вып. XLVI. – М., 1993.
3. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей : принята в г. Нью-Йорке 30.09.1990 // Дипломатический вестник. – 1992. – № 4.
4. Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 // Российская газета. – 2020. – 4 июля.
5. Семейный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ : ред. от 31.07.2023 // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 16.
6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ : ред. от 24.07.2023 // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.
7. Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ : ред. от 23.03.2024 // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
8. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации : федер. закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ : ред. от 28.04.2023 // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3802.
9. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних : федер. закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ : ред. от 21.11.2022 // Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3177.
10. О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей : федер. закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ : ред. от 04.08.2023 // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 52. – Ст. 5880.
11. Об опеке и попечительстве : федер. закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ : ред. от 30.04.2021 // Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 17. – Ст. 1755.
12. О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей : федер. закон от 16.04.2001 № 44-ФЗ : ред. от 02.08.2019 // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 17. – Ст. 1643.
13. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» : федер. закон от 02.07.2013 № 185-ФЗ // Российская газета. – 2013. – 10 июля. – № 148.
14. Об утверждении комплекса мер по предоставлению детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа жилых помещений на 2019–2021 годы : распоряжение Правительства РФ от 06.04.2019 № 656-р // Собрание законодательства РФ. – 2019. – № 15. – Ст. 1793.
15. Об утверждении Примерных положений о специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации : постановление Правительства РФ от 27.11.2000 № 896 : ред. от 10.03.2009 // Российская газета. – 2000. – 9 дек. – № 235.
16. О полномочиях Министерства образования и науки Российской Федерации по оказанию содействия в устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи : постановление Правительства РФ от 10.03.2005 № 123 : ред. от 19.12.2018 // Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 11. – Ст. 950.

17. О деятельности органов и организаций иностранных государств по усыновлению (удочерению) детей на территории Российской Федерации и контроле за ее осуществлением : постановление Правительства РФ от 04.11.2006 № 654 : ред. от 19.12.2018 // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 46. – Ст. 4801.
18. Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных услуг… : постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 352 : ред. от 15.09.2020 // Российская газета. – 2011. – 18 мая. – № 104.
19. О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг : постановление Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 : ред. от 03.11.2018 // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 22. – Ст. 3169.
20. Об утверждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или патронатную семью : постановление Правительства РФ от 14.02.2013 № 117 : ред. от 11.07.2020 // Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 36. – Ст. 4577.
21. Об утверждении Порядка формирования, ведения и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей : приказ Минобрнауки России от 17.02.2015 № 101 // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 23.03.2025).
22. Об отдельных правоотношениях в сфере опеки и попечительства на территории Орловской области : закон Орловской области от 03.11.2022 № 2825-ОЗ // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/5700202211030025 (дата обращения: 12.03.2025).
23. О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Орловской области : закон Орловской области от 03.11.2022 № 2819-ОЗ : с изм. и доп. // Официальный сайт Правительства Орловской области. – URL: https://www.orel-gov.ru/doc/64879 (дата обращения: 12.03.2025).
24. Об отдельных правоотношениях, связанных с реализацией основных гарантий прав ребенка в Орловской области : закон Орловской области от 03.11.2022 № 2818-ОЗ // Официальный сайт Правительства Орловской области. – URL: https://www.orel-gov.ru/doc/64871 (дата обращения: 12.03.2025).
25. О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Орловской области : закон Орловской области от 26.12.2014 № 1730-ОЗ // Официальный сайт Правительства Орловской области. – URL: https://www.orel-gov.ru/doc/48901 (дата обращения: 12.03.2025).
26. Об Уполномоченном по правам ребенка в Орловской области : закон Орловской области от 05.07.2019 № 2357-ОЗ // Официальный сайт Правительства Орловской области. – URL: https://www.orel-gov.ru/doc/58119 (дата обращения: 12.03.2025).
27. Об утверждении Порядка (алгоритма) неотложных межведомственных действий при установлении факта нахождения несовершеннолетних в обстановке, не отвечающей требованиям к их воспитанию и содержанию : постановление Правительства Орловской области от 06.07.2017 № 2965 // Официальный сайт Правительства Орловской области. – URL: https://www.orel-gov.ru/doc/26262 (дата обращения: 12.03.2025).
28. О дополнительной социальной поддержке лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей : закон Орловской области от 27.12.2021 № 2722-ОЗ // Официальный сайт Правительства Орловской области. – URL: https://www.orel-gov.ru/doc/63103 (дата обращения: 12.03.2025).

29. О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области отдельными государственными полномочиями Орловской области в сфере опеки и попечительства : закон Орловской области от 06.12.2007 № 732-ОЗ : с изм. и доп. // Официальный сайт Правительства Орловской области. – URL: https://www.orel-gov.ru/doc/38877 (дата обращения: 12.03.2025).
30. Березин, Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека / Ф.Б. Березин. – СПб. : Питер, 2016. – 342 с.
31. Вавилова, Л.Н. Коррекция девиантного поведения у воспитанников детского дома : дис. … канд. пед. наук / Л.Н. Вавилова. – Калининград, 2015. – 152 с.
32. Выготский, Л.С. Собрание сочинений : в 4 т. / Л.С. Выготский. – М. : Педагогика, 2015. – Т. 1–4.
33. Гринёв, Е.А. Технологии социальной работы с девиантной молодежью / Е.А. Гринёв // Социокультурный менеджмент: содержание, проблемы, перспективы : материалы III Междунар. науч.-практ. конф. / под ред. И.А. Плоховой. – Ульяновск : УлГПУ, 2015. – С. 120–128.
34. Гусева, Т.С. Комментарий к Федеральному закону от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (постатейный) / Т.С. Гусева, О.В. Шашкова. – М. : СПС «КонсультантПлюс», 2012.
35. Детская безнадзорность и беспризорность: проблемы, профилактика : материалы межрегион. науч.-практ. конф. – Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2015. – 341 с.
36. Дубровина, И.В. Особенности психического развития детей в семье и вне семьи / И.В. Дубровина. – М. : Медицина, 1982. – 326 с.
37. Дудкин, А.С. Технологии социальной работы с семьей и детьми : учеб. пособие / А.С. Дудкин. – Пенза : ПГПУ им. В.Г. Белинского, 2016. – 140 с.
38. Егорова, М.О. Профилактика сиротства – как актуальная задача социальных служб / М.О. Егорова // Социальная работа. – 2016. – № 5. – С. 13–14.
39. Иванова, Н.П. Адаптация детей в замещающей семье : пособие / Н.П. Иванова, И.А. Бобылева. – М. : БФРГТЗ «Слово», 2015. – 325 с.
40. Иванова, Н.П. Основные законодательные и другие нормативно-правовые акты РФ по защите прав ребенка : сб.-справ. / Н.П. Иванова, Е.И. Рыбинский. – М. : Слово, 2017. – 425 с.
41. Козырева, А. На полпути от улицы к детдому / А. Козырева // Российская газета. – 2007. – 16 сент. – С. 9.
42. Личко, А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков / А.Е. Личко. – СПб. : Питер, 2013. – 256 с.
43. Малярова, Н.З. Социальная защита детства: концептуальный подход / Н.З. Малярова // Социологические исследования. – 2015. – № 4. – С. 45–58.
44. Мардахаев, Л.В. Социальная педагогика : учебник / Л.В. Мардахаев. – М. : Юрайт, 2015. – 364 с.
45. Мельников, В.П. История социальной работы в России : учеб. пособие / В.П. Мельников, Е.И. Холостова. – М. : Дашков и К°, 2006. – 334 с.
46. Министерство просвещения Российской Федерации : офиц. сайт. – URL: https://edu.gov.ru (дата обращения: 04.02.2025).
47. Мустаева, Ф.А. Социальная педагогика : учебник для вузов / Ф.А. Мустаева. – М. : Академический Проект, 2013. – 528 с.
48. Олиференко, Л.Я. Инновации в работе специалистов социально-педагогических учреждений / Л.Я. Олиференко ; под ред. Е.Е. Чепурных, Т.И. Шульги, А.В. Быкова. – М. : Полиграф сервис, 2016. – 264 с.
49. Организация работы органов социальной защиты : учеб. пособие / под ред. А.Н. Савинова, Т.Ф. Зарембо. – М. : Академия, 2016. – 321 с.

50. Основы социальной работы : учебник / отв. ред. П.Д. Павленок. – М. : ИНФРА-М, 2016. – 234 с.
51. Откуда берутся дети, оставшиеся без попечения родителей [Электронный ресурс]. – URL: https://isppp.site/portfolio/obpr/ (дата обращения: 20.05.2025).
52. Платонова, Н.М. Теория и методика социальной работы : учебник / Н.М. Платонова. – М. : Академия, 2016. – 213 с.
53. Поповичева, Л.И. Социальная работа с детьми из неблагополучных семей в ДОУ / Л.И. Поповичева, М.Д. Масанова, Н.И. Федотова. – М. : Слово, 2015. – 401 с.
54. Пронина, А.Н. Исследование взаимосвязей между структурными компонентами социализации и индивидуализмом личности детей-сирот дошкольного возраста / А.Н. Пронина // Мир психологии. – 2010. – № 1. – С. 45–51.
55. Фоминых, Е.С. Проблема виктимогенного потенциала в феноменологии сиротства – социальная депривация как фактор формирования позиции жертвы / Е.С. Фоминых // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология. – 2016. – № 3 (26). – С. 100–104.
56. Циткилов, П.Я. Технология социальной работы : учеб. пособие / П.Я. Циткилов. – М. : Дашков и К°, 2016. – 448 с.
57. Шахманова, А.Ш. Воспитание детей-сирот дошкольного возраста / А.Ш. Шахманова ; под ред. С.А. Козловой. – М. : Академия, 2015. – 192 с.
58. Шипицына, Л.М. Психология детей-сирот : учеб. пособие / Л.М. Шипицына. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. – 345 с.
59. Холостова, Е.И. Социальная работа : учебник для бакалавров / Е.И. Холостова. – М. : Дашков и К°, 2015. – 612 с.
60. Панов, А.М. Социальная работа как наука, вид профессиональной деятельности и специальность в системе высшего образования / А.М. Панов // Российский журнал социальной работы. – 1995. – № 1. – С. 9–17.
61. Алексеева, Л.С. Социальная работа с семьей в учреждениях социального обслуживания / Л.С. Алексеева // Семья в России. – 2014. – № 2. – С. 45–56.
62. Мухина, В.С. Возрастная психология. Феноменология развития : учебник / В.С. Мухина. – 15-е изд., стер. – М. : Академия, 2015. – 656 с.
63. Бардышевская, М.К. Развитие привязанности у эмоционально депривированных детей / М.К. Бардышевская // Дефектология. – 2013. – № 2. – С. 12–22.
64. Сафонова, Т.Я. Жестокое обращение с детьми: сущность, причины, социально-правовая защита / Т.Я. Сафонова, Е.И. Цымбал. – М. : ВНИИ МВД России, 2014. – 168 с.
65. Плясова, Н.Ф. Социальная работа с детьми, оставшимися без попечения родителей / Н.Ф. Плясова // Отечественный журнал социальной работы. – 2015. – № 3. – С. 78–86.
66. Топчий, Л.В. Организация деятельности социальных служб по работе с семьей и детьми / Л.В. Топчий. – М. : Социально-технологический институт, 2014. – 214 с.
67. Басов, Н.Ф. Социальный работник: профессиональная деятельность и подготовка кадров / Н.Ф. Басов. – М. : Дашков и К°, 2015. – 248 с.
68. Галагузова, М.А. Социальная педагогика : учебник / М.А. Галагузова, Ю.Н. Галагузова, Г.Н. Штинова. – М. : ВЛАДОС, 2016. – 416 с.
69. Галагузова, Ю.Н. Социальная педагогика: практика глазами преподавателей и студентов : пособие / Ю.Н. Галагузова, Г.Н. Штинова. – М. : ВЛАДОС, 2015. – 224 с.
70. Дементьева, И.Ф. Социальное сиротство: генезис и профилактика / И.Ф. Дементьева. – М. : Государственный НИИ семьи и воспитания, 2014. – 128 с.
71. Ослон, В.Н. Жизнеустройство детей-сирот: профессиональная замещающая семья / В.Н. Ослон. – М. : Генезис, 2016. – 368 с.
72. Бобылева, И.А. Социальная адаптация выпускников интернатных учреждений : учеб.-метод. пособие / И.А. Бобылева. – М. : БФРГТЗ «Слово», 2015. – 176 с.

73. Прихожан, А.М. Психология сиротства / А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых. – 3-е изд. – СПб. : Питер, 2015. – 416 с.
74. Ослон, В.Н. Замещающая профессиональная семья как условие компенсации последствий депривации у детей-сирот / В.Н. Ослон // Психологическая наука и образование. – 2014. – № 3. – С. 64–74.
75. Фирсов, М.В. Теория социальной работы : учебник / М.В. Фирсов, Е.Г. Студенова. – М. : Академический Проект, 2016. – 512 с.
76. Топчий, Л.В. Кадровое обеспечение социальных служб: состояние и перспективы развития / Л.В. Топчий. – М. : Изд-во МГСУ, 2013. – 198 с.
77. Беличева, С.А. Основы превентивной психологии / С.А. Беличева. – М. : Социальное здоровье России, 2014. – 224 с.
78. Никитина, Л.Е. Социальный педагог в школе / Л.Е. Никитина. – М. : Академический Проект, 2015. – 176 с.
79. Шульга, Т.И. Работа с неблагополучной семьей : учеб. пособие / Т.И. Шульга. – М. : Дрофа, 2015. – 254 с.
80. Холостова, Е.И. Социальная работа с дезадаптированными детьми : учеб. пособие / Е.И. Холостова. – М. : Дашков и К°, 2012. – 272 с.
81. Рыбинский, Е.М. Управление системой социальной защиты детства: социально-правовые проблемы / Е.М. Рыбинский. – М. : Академия, 2014. – 240 с.
82. Нечаева, А.М. Семейное право : курс лекций / А.М. Нечаева. – М. : Юристъ, 2015. – 320 с.
83. Козлова, С.А. Дошкольная педагогика : учебник / С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – М. : Академия, 2015. – 416 с.
84. Ярская-Смирнова, Е.Р. Социальная политика и социальная работа в изменяющейся России / Е.Р. Ярская-Смирнова, П.В. Романов. – М. : ИНИОН РАН, 2014. – 288 с.
85. Ромм, Т.А. Социальное воспитание: эволюция теоретических образов / Т.А. Ромм. – Новосибирск : Наука, 2015. – 256 с.
86. Семья, Г.В. Основы психологической защищенности детей, оставшихся без попечения родителей / Г.В. Семья. – М. : Просвещение, 2015. – 192 с.
87. Морозова, Е.А. Правовая культура выпускников интернатных учреждений / Е.А. Морозова // Вопросы ювенальной юстиции. – 2016. – № 2. – С. 18–23.
88. Зайнышев, И.Г. Технология социальной работы : учеб. пособие / И.Г. Зайнышев. – М. : ВЛАДОС, 2014. – 240 с.
89. Гурко, Т.А. Теоретические подходы к изучению семьи / Т.А. Гурко // Социологические исследования. – 2015. – № 1. – С. 35–44.
90. Кузнецова, Л.П. Основные технологии социальной работы : учеб. пособие / Л.П. Кузнецова. – Владивосток : Изд-во ДВГТУ, 2014. – 162 с.
91. Гуслова, М.Н. Теория и методика социальной работы : учебник / М.Н. Гуслова. – М. : Академия, 2015. – 288 с.
92. Климентьева, Н.Ю. Сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей / Н.Ю. Климентьева, Г.В. Семья // Социальная педагогика. – 2016. – № 4. – С. 55–63.
93. Мудрик, А.В. Социальная педагогика : учебник / А.В. Мудрик. – М. : Академия, 2015. – 240 с.
94. Бочарова, В.Г. Педагогика социальной работы / В.Г. Бочарова. – М. : Аргус, 2014. – 208 с.
95. Брутман, В.И. Раннее социальное сиротство как комплексная медико-социально-педагогическая проблема / В.И. Брутман, М.Г. Панкратова, С.Н. Ениколопов // Вопросы психологии. – 2013. – № 5. – С. 44–52.
96. Капилина, М.В. Психологическая помощь детям в учреждениях интернатного типа / М.В. Капилина, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева. – СПб. : Речь, 2014. – 256 с.

97. Антонов, А.И. Микросоциология семьи : учебник / А.И. Антонов. – М. : ИНФРА-М, 2015. – 368 с.
98. Зубкова, Т.С. Организация и содержание работы по социальной защите женщин, детей и семьи : учеб. пособие / Т.С. Зубкова, Н.В. Тимошина. – М. : Академия, 2014. – 224 с.
99. Курбатов, В.И. Социальная работа : учеб. пособие / В.И. Курбатов. – Ростов н/Д : Феникс, 2015. – 480 с.
100. Тетерский, С.В. Введение в социальную работу : учеб. пособие / С.В. Тетерский. – М. : Академический Проект, 2014. – 496 с.
101. Фришман, И.И. Методика работы педагога дополнительного образования / И.И. Фришман. – М. : Академия, 2015. – 160 с.
102. Павленок, П.Д. Теория, история и методика социальной работы : избр. работы / П.Д. Павленок. – М. : Дашков и К°, 2015. – 568 с.
103. Кононова, Л.И. Технология социальной работы : учебник / Л.И. Кононова, Е.И. Холостова. – М. : Юрайт, 2016. – 503 с.
104. Григорьев, С.И. Социальная работа с молодежью : учебник / С.И. Григорьев, Л.Г. Гуслякова, С.И. Гусев. – М. : Гардарики, 2014. – 336 с.
105. Семья, Г.В. Социально-психологические технологии профилактики социального сиротства / Г.В. Семья // Семья. – 2016. – № 3. – С. 12–19.
106. Галагузова, Г.Н. Методика и технология работы социального педагога : учеб. пособие / Г.Н. Галагузова, Л.В. Мардахаев. – М. : Академия, 2014. – 192 с.